

Buku Referensi **EDUKASI NUTRISI UNTUK IBU MENYUSUI**

Suryani Hartati • Vika Tri Zelharsandy • Sri Raudhati
Betty Yosephin Simanjuntak • Yuni Kristiani Tumani
Ranny Septiani



BUKU REFERENSI EDUKASI NUTRISI UNTUK IBU MENYUSUI

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.

Sri Raudhati, S.SiT., M.K.M.

Dr. Betty Yosephin Simanjuntak, SKM., MKM.

Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.

Bdn. Ranny Septiani, SST., M.Keb



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

EDUKASI NUTRISI UNTUK IBU MENYUSUI

Penulis: Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.

Sri Raudhati, S.SiT., M.K.M.

Dr. Betty Yosephin Simanjuntak, SKM., MKM.

Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.

Bdn. Ranny Septiani, SST., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9618-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul "Edukasi Nutrisi untuk Ibu Menyusui" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya pemberian nutrisi optimal selama masa menyusui demi mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antarprofesional, melibatkan tenaga ahli kebidanan dan keperawatan maternitas, serta ahli gizi yang berkompeten di bidangnya, dengan harapan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas edukasi dan pelayanan kesehatan ibu menyusui.

Kami menyadari bahwa masih banyak ibu menyusui yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pengetahuan tentang nutrisi yang tepat hingga berbagai masalah fisik maupun psikologis dalam menyusui. Oleh karena itu, buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif, meliputi aspek penting terkait asupan nutrisi, edukasi pola makan sehat, kolaborasi profesional dalam mendukung menyusui, serta dampak kurang gizi terhadap pertumbuhan bayi. Kami percaya, dengan pendekatan yang terintegrasi dan edukasi yang tepat, kualitas kehidupan ibu dan anak dapat meningkat secara signifikan.

Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran, materi, maupun dukungan moral dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih khususnya kepada tim Optimal yang telah membantu desain dan penataan buku sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi ilmiah dan panduan praktis bagi para tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengaplikasikan nutrisi seimbang bagi ibu menyusui.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENTINGNYA ASUPAN NUTRISI BAGI IBU MENYUSUI	1
A. Pendahuluan	1
B. Ibu Nifas dan Menyusui.....	1
C. Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui	2
D. Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Nutrisi	4
E. Status Nutrisi Ibu Menyusui.....	4
F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nutrisi Ibu Menyusui	5
G. Nutrisi Seimbang Selama Menyusui.....	7
H. Panduan Makanan Bagi Ibu Menyusui.....	8
I. Penutup.....	9
Referensi.....	11
BAB II MAKANAN YANG MENDUKUNG PRODUKSI ASI.....	14
A. Pendahuluan	14
B. Makanan Pelancar Produksi ASI.....	15
C. Contoh Menu Harian Untuk Ibu Menyusui yang Mendukung Produksi ASI	21
D. Peran Asuhan Kebidanan Komplementer dalam Meningkatkan Produksi ASI..	22
E. Penutup	24
Referensi.....	26
BAB III PENGARUH NUTRISI TERHADAP KUALITAS ASI.....	32
A. Pendahuluan	32
B. Kualitas ASI	32
C. Asupan ibu Menyusui	34
D. Peran Asupan Ibu dalam Meningkatkan Kualitas ASI.....	37
E. Penutup	42
Referensi.....	43
BAB IV EDUKASI IBU MENYUSUI TENTANG POLA MAKAN SEHAT.....	46
A. Pendahuluan	46
B. Edukasi Nutrisi Ibu Menyusui	47
C. Gizi Ibu Menyusui terkait Pola Makan Sehat	49
D. Peran Perawat Dalam Melakukan Edukasi Pada Ibu Menyusui.....	51
E. Penutup	55
Referensi.....	57
BAB V KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM MENDUKUNG IBU MENYUSUI.	59
A. Pendahuluan	59
B. Peran Bidan dalam Mendukung Ibu Menyusui.....	60
C. Peran Ahli Gizi dalam Mendukung Ibu Menyusui.....	62

D. Model Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi.....	64
E. Studi Kasus dan Implementasi di Lapangan	66
F. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi.....	68
G. Penutup.....	70
Referensi.....	72
BAB VI DAMPAK KURANG GIZI PADA IBU MENYUSUI TERHADAP	
PERTUMBUHAN BAYI.....	74
A. Pendahuluan	74
B. Konsep Gizi Dan Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui	74
C. Kurang Gizi Pada Ibu Menyusui	74
D. Penyebab Kekurangan Gizi Pada Ibu Menyusui	75
E. Dampak Kurang Gizi Ibu Menyusui Terhadap Bayi	76
F. Penilaian Bayi Yang Mengalami Kekurangan Gizi.....	83
G. Dampak Kekurangan Gizi Pada Ibu Menyusui	84
H. Persyaratan Nutrisi.....	84
I. Solusi Dan Intervensi.....	85
J. Dukungan Pemerintah Dan Kebijakan.....	85
K. Penutup	86
Referensi.....	87
Profil Penulis.....	90

BAB I

PENTINGNYA ASUPAN NUTRISI BAGI IBU MENYUSUI

A. Pendahuluan

Gizi ibu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan generasi mendatang. Beberapa penelitian mengaitkan kekurangan nutrisi ibu dengan berat badan lahir rendah, risiko penyakit menular, serta hambatan pertumbuhan dan keterlambatan perkembangan pada anak (Siregar et al. 2024). Nutrisi yang cukup selama menyusui sangat krusial guna memastikan kesehatan yang baik pada ibu serta bayinya (Carretero-Krug et al., 2024).

Masalah yang biasanya ibu menyusui sering temui adalah kurangnya pengetahuan ibu perihal tahapan menyusui bayi. Ibu menyusui sering mengalami puting lecet, terjadinya bendungan ASI (Air Susu Ibu), nyeri payudara sehingga membuat ibu menyusui tidak mau menyusui bayinya. Masalah lain layaknya kurangnya pengetahuan ibu terhadap asupan nutrisi yang dibutuhkan saat ibu menyusui (Mufida et al., 2022).

Salah satu komponen terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh adalah nutrisi. Kesehatan ibu dan anak dapat dipengaruhi oleh nutrisi. Menjaga pola makan yang sehat berkaitan dengan harapan hidup yang lebih panjang, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan kemungkinan terkena penyakit degeneratif yang lebih rendah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, prinsip dasar dari kepuasan nutrisi adalah mengonsumsi berbagai jenis makanan dalam proporsi yang seimbang. Asupan nutrisi harian biasanya meningkat untuk semua ibu menyusui. Masalah gizi jangka panjang dapat mengubah beberapa komponen dalam ASI, meskipun ibu yang memiliki masalah gizi masih bisa melakukan produksi ASI (Nikmah & Anggraeni, 2023).

B. Ibu Nifas dan Menyusui

Masa enam minggu atau empat puluh dua hari setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali ke bentuk sebelum kehamilan dikenal sebagai masa nifas (Post Partum). Ibu akan mengalami banyak perubahan fisiologis tubuh selama fase pemulihan, yang akan menyebabkan banyak rasa sakit pada masa awal nifas. Bila tidak memperoleh perawatan yang sesuai, perihal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan patologis.

Wanita yang memberikan air susu ibu (ASI) pada bayi baru lahir atau anak kecil dikenal sebagai ibu menyusui. Menyusui adalah praktik alami yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ibu menyusui memiliki fungsi yang sangat penting. Baik untuk kesehatan pribadinya maupun untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menyusui memiliki banyak manfaat, termasuk menurunkan depresi dan menghindari infeksi menular.

Menurut KEMENKES (2020), ibu yakni perempuan yang telah melahirkan seorang anak; ini yaitu sebutan yang umum bagi perempuan, baik yang telah menikah ataupun belum. Praktik memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayi atau anak kecil dari payudara ibu dikenal sebagai menyusui. Bayi mendapatkan dan mengonsumsi ASI dengan menggunakan refleks menghisap. Seluruh nutrisi yang diperlukan bayi guna pertumbuhan serta kesehatannya dalam beberapa tahun pertama kehidupannya terdapat dalam ASI. Pemberian ASI eksklusif adalah praktik yang merekomendasikan agar bayi yang baru lahir atau bayi berusia 0 hingga 6 bulan hanya minum ASI. Sebenarnya tidak terlalu kaku dalam hal diet ibu menyusui; yang paling penting yakni makanan yang memberi jaminan produksi ASI bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup guna mencukupi keperluan bayi. Sangat penting untuk mempertimbangkan kriteria berikut saat membuat menu untuk ibu menyusui: menu tersebut harus seimbang, selaras dengan pedoman, bebas dari pantangan makanan (terkecuali ibu memiliki alergi terhadap bahan terkhusus), mudah dicerna, serta tidak terlalu merangsang sistem pencernaan.

C. Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui

Menurut (Fatimah, Rahma Delia, A., Nurdiyanah, & Damayanti, 2022) keperluan dasar ibu nifas yakni berikut ini:

1. Nutrisi serta Cairan Masalah nutrisi perlu memperoleh perhatian dikarenakan dengan nutrisi yang baik bisa menjadikan lebih cepat penyembuhan ibu serta sangat memberi dampak pada susunan air susu. Kebutuhan gizi ibu saat menyusui adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi tambahan kalori 500 kalori tiap hari
 - b. Diet berimbang vitamin, mineral, serta protein
 - c. Minum paling sedikit 2 liter tiap hari (+8 gelas)
 - d. Fe/tablet tambah darah hingga 40 hari pasca persalinan
 - e. Kapsul Vit. A 200.000 unit
2. Ambulasi dini yakni praktik profesional kesehatan yang membantu ibu baru untuk bangun dari tempat tidur sesegera mungkin sehingga mereka dapat

berjalan sesegera mungkin. Dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah melahirkan, ibu pascapersalinan diperbolehkan meninggalkan tempat tidurnya. Hal ini dilakukan secara bertahap. Pada ibu nifas yang mengalami kesulitan layaknya anemia, penyakit paru-paru, penyakit jantung, demam, serta sebagainya, ambulasi dini tidak disarankan. Manfaat berjalan lebih awal:

- a. Ibu merasa lebih sehat
 - b. Fungsi usus serta kandung kemih lebih baik.
 - c. Kita memberi pembelajaran ibu guna merawat bayinya.
 - d. Tidak terdapat dampak buruk pada proses pasca persalinan, tidak memberi pengaruh penyembuhan luka, tidak mengakibatkan perdarahan, tidak menjadikan lebih besar kemungkinan retrotexto uteri atau prolapsus
3. Eliminasi. Ibu dapat berkemih enam jam setelah melahirkan; jika tidak, kateterisasi disarankan bila kandung kemih penuh atau sudah lebih dari delapan jam tidak berkemih. Faktor-faktor berikut ini berkontribusi pada kesulitan berkemih pascapersalinan (predlo urine): penurunan tekanan intra-abdomen.
- a. Dinding kandung kemih kurang sensitive
 - b. Otot-otot perut masih lemah.
 - c. Uretra serta edema
 - d. Ibu post partum diinginkan terdapat defekasi atau BAB sesudah hari kedua post partum bila hari ketiga belum defekasi dapat diberi obat rektal atau pencahar oral.
4. Kebersihan diri Seorang wanita lebih rentan pada infeksi selama fase pascapersalinan. Maka dari itu, menjaga kebersihan lingkungan, pakaian, kasur, serta tubuh sangatlah penting. Berikut ini adalah tindakan yang dapat dilakukan:
- a. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh terkhusus perineum
 - b. Mengajarkan ibu cara memberikan alat kelamin dengan sabun dan air dari depan ke belakang.
 - c. Diberikan saran ibu ganti pembalut setidaknya dua kali sehari .
 - d. Melakukan pembersihan tangan dengan sabun serta air sebelum serta setelah melakukan pembersihan alat kelamin.
 - e. Bila ibu memiliki luka episiotomi atau laserasi luka jahit pada alat kelamin, memberi saran guna tidak menyentuh daerah terkait.

Tingkat asupan menentukan status kesehatan gizi. Jumlah dan kualitas makanan memengaruhi tingkat konsumsi. Kehadiran semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam komposisi makanan dan rasio antara satu nutrisi dengan nutrisi lainnya merupakan tanda kualitasnya. Kuantitas menunjukkan seberapa banyak setiap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh akan mendapatkan kondisi nutrisi yang optimal, yang dikenal sebagai asupan yang cukup, jika rencana makan memenuhi kebutuhannya baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Agar seorang wanita menyusui dapat menyusui anaknya dengan baik, ia membutuhkan tambahan 300-500 kalori setiap harinya. Wanita menyusui dapat mempertahankan asupan gizi yang seimbang dengan mengikuti pedoman saat ini, yaitu tabel AKG, daripada makan berlebihan.

D. Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Nutrisi

Pemahaman ibu pascapersalinan tentang nutrisi ibu menyusui meningkat. Wanita harus mengonsumsi lebih banyak kalori saat menyusui daripada saat hamil. Ada sekitar sepuluh rekomendasi untuk gizi seimbang. (Wati et al., 2021):

1. Jadikan kebiasaan untuk melakukan konsumsi aneka ragam makanan pokok
2. Batasi konsumsi pangan berlemak, asin, serta manis
3. Ibu hamil bisa menjalankan kegiatan fisik yang selaras dengan kehamilan serta terbukti aman
4. Konsumsi lauk pauk yang memiliki tinggi protein dengan teratur
5. Senantiasa cuci tangan dengan sabun serta air mengalir
6. Biasakan sarapan pagi
7. Penuhi keperluan air serta cairan selaras kebutuhan
8. Banyak makan buah dan sayur
9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan
10. Syukuri serta nikmati aneka ragam makanan

E. Status Nutrisi Ibu Menyusui

Kondisi tubuh manusia sebagai fungsi dari asupan makanan dan penggunaan nutrisi dikenal sebagai status gizi. Gizi lebih, gizi cukup, serta gizi kurang adalah tiga jenis status gizi. Asupan makanan dan kesehatan atau penyakit tubuh adalah dua faktor utama yang memengaruhi kondisi gizi seseorang. Malnutrisi, sebuah kondisi patologis yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan relatif atau absolut dari satu atau lebih zat gizi, adalah istilah yang digunakan dalam penelitian gizi untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan gizi. Berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, serta IMT adalah ukuran antropometri yang dapat digunakan untuk

menilai kondisi gizi ibu menyusui. Berikut ini adalah kategorisasi status gizi ibu menyusui:

1. Obesitas (obese) $> +3$ SD
2. Gizi kurang (wasted) -3 SD sd <-2 SD
3. Gizi baik (normal) -2 SD sd $+1$ SD
4. Berisiko gizi lebih ($> +1$ SD sd $+2$ SD)
5. Gizi lebih (overweight) $> +2$ SD sd $+3$ SD
6. Gizi buruk (severely wasted) <-3 SD

F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nutrisi Ibu Menyusui

Berlandaskan Suciti dan Wulandari (2020), kelancaran ASI yang diberikan ibu menyusui kepada bayinya berdampak langsung pada kecukupan gizi bayi. Produksi ASI akan meningkat jika kebutuhan nutrisi ibu menyusui terpenuhi. Untuk memperlancar produksi ASI yang lancar, ibu menyusui harus mengikuti pola makan dan konsumsi makanan yang seimbang. Yang lebih menarik lagi, keberhasilan menyusui juga sangat dipengaruhi oleh status gizi sebelum melahirkan.

Situasi keuangan keluarga juga berdampak pada kepuasan nutrisi ibu menyusui. Kemampuan keluarga untuk membeli makanan seimbang yang dibutuhkan ibu menyusui berkorelasi langsung dengan status ekonomi. Kemampuan untuk menyediakan makanan yang sehat bagi keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan gizi ibu menyusui, meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan keluarga. Pilihan bahan makanan berkualitas tinggi dan padat gizi dipengaruhi oleh tingkat keuangan keluarga. (2019, Hidayatunnikmah).

Ketidaktahuan ibu menyusui tentang diet seimbang adalah faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kecukupan gizi. Pengetahuan individu dan tingkat pendidikan sering dikaitkan. Pendidikan yang lebih tinggi dianggap memiliki dampak pada bagaimana orang memproses informasi yang mereka dapatkan, sehingga mereka dapat mencerna dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari lingkungannya. Akibatnya, sejumlah penelitian sering menemukan bahwa pendidikan dan keahlian ibu menyusui berdampak pada suplai ASI dan kecukupan gizi (Suciati & Wulandari, 2020).

Rahmawati (2020) menegaskan bahwa sejumlah variabel memengaruhi bagaimana pola makan ibu menyusui terbentuk, termasuk:

1. Faktor internal yakni faktor yang dibentuk dari dalam diri ibu sendiri.

Mencakup:

- a. Usia
- b. Pekerjaan

- c. Pendidikan
 - d. Pengetahuan
2. Faktor eksternal yakni yang berkaitan dengan pola makan ibu menyusui mencakup:
- a. Budaya berpantang makanan
 - b. Sosial ekonomi pendapatan

Situasi Keuangan Ketersediaan pangan keluarga diberi pengaruh oleh kondisi ekonomi. Daya beli atau uang keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan pangan serta ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pekerjaan dan pendidikan berkorelasi positif dengan pendapatan keluarga. Selain usia serta jenis kelamin, status sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti uang, pekerjaan, dan pendidikan menentukan kualitas konsumsi pangan (Marmoot, 2010). Makanan segar, yang mempunyai daya beli yang lebih besar daripada makanan cepat saji serta tinggi lemak, secara langsung berkaitan dengan asupan gizi yang seimbang (Kakiay & Wigiyanti, 2022).

Seseorang dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mengonsumsi lebih banyak lemak dan lebih sedikit buah dan sayuran. Sebaliknya, seseorang dengan posisi sosial ekonomi tinggi akan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung buah-buahan, sayuran, daging tanpa lemak, serta makanan rendah lemak lainnya guna meningkatkan status gizinya.

Ketersediaan pangan keluarga secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan sosial ekonomi. Daya beli atau uang yang dimiliki keluarga berdampak pada ketersediaan pangan serta ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pendapatan adalah hasil dari suatu pekerjaan atau usaha. Pendapatan berdampak pada bagaimana sebuah keluarga membiayai pengeluarannya (Hidayatunnikmah, 2019).

Upah pokok, tunjangan, bonus, dan pendapatan lainnya adalah beberapa komponen yang membentuk pengukuran pendapatan; jika rumah tangga menerima berbagai sumber pendapatan, total pendapatan mereka akan meningkat. Jumlah dan kualitas kategori makanan meningkat seiring dengan meningkatnya kekayaan keluarga. Makanan yang dibeli tergantung pada pendapatan keluarga; semakin besar pendapatan, semakin banyak uang yang dibelanjakan. Dengan demikian, salah satu elemen yang memengaruhi pilihan jumlah dan kualitas makanan bergizi adalah uang (Taqiyah et al., 2022).

- c. Informasi nutrisi laktasi

d. Pengetahuan

Pengetahuan adalah capaian dari penginderaan manusia, atau tahu, serta ini terjadi sesudah orang memakai panca indera mata, telinga, hidung, serta sebagainya guna mengamati suatu objek.

G. Nutrisi Seimbang Selama Menyusui

Ibu menyusui membutuhkan diet yang seimbang karena merekalah yang berjuang untuk mendapatkan ASI. Mereka tidak bisa makan apa saja yang mereka inginkan. Karena bayi akan terpengaruh oleh makanan ibu melalui ASI. Para ibu harus menjauhi makanan pedas, makanan yang tajam, dan kafein karena dapat menyebabkan kembung, diare, alergi, dan masalah lain untuk bayi. Komponen-komponen berikut ini adalah bagian dari kebutuhan makanan ibu menyusui (Nikmah & Anggraeni, 2023):

1. Energi

Ibu menyusui membutuhkan tambahan 330 kkal energi makanan pada enam bulan pertama dan 400 kkal pada enam bulan kedua untuk memproduksi ASI. Makanan mengandung 100-150 kkal dari lemak tubuh ibu yang tersimpan. Perhitungan ini dilandaskan pada gagasan bahwa sekitar 85 kkal energi dibutuhkan untuk membuat 100 cc ASI.

2. Protein

Selama enam bulan pertama menyusui, ibu membutuhkan tambahan 20 g protein setiap hari. Perhitungan ini didasarkan pada gagasan bahwa ada 1,2 g protein dalam 100 cc ASI.

3. Lemak

Tingkat lemak seorang ibu dapat berdampak pada seberapa banyak ASI yang dihasilkannya. Oleh karena itu, ibu menyusui memerlukan asupan lemak.

4. Karbohidrat

Ketika menyusui, ibu memerlukan tambahan karbohidrat antara 160-200 g/hari.

5. Vitamin

Vitamin Seorang ibu memerlukan lebih banyak vitamin daripada sebelum hamil, terkecuali vitamin D serta K, karena apa yang dia makan berdampak pada janin yang dikandungnya. Kekurangan vitamin pada ibu menyusui mengakibatkan kandungan vitamin yang lebih rendah dalam ASI.

6. Mineral

Mineral Dengan pengecualian Ca, P, Mg, F, dan Mo, ibu menyusui membutuhkan lebih banyak mineral dibandingkan ibu hamil. ibu

membutuhkan lebih sedikit zat besi dibandingkan ibu yang tidak hamil selama masa nifas.

7. Air

Air Seiring dengan bertambahnya jumlah ASI yang diproduksi, begitu pula dengan kebutuhan air ibu menyusui. Oleh karena itu, disarankan agar ibu minum satu gelas air setelah menyusui untuk mengisi kembali ASI yang keluar.

Kandungan kalori, protein, karbohidrat, serta lemak dalam 100 g makanan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Energi, Protein, Karbohidrat Dan Lemak per 100 gr

Nama Bahan Makanan	Energi (Kkal)	Protein (g)	Karbohidrat (g)	Lemak (g)	Jumlah Porsi (P)
Nasi	178	2,1	40,6	0,1	1
Daging Sapi	207	18,8	0	4	1
Tahu	68	7,8	1,6	4,6	1
Kangkung		3,0	5,4	0,3	1
Pisang	99	1,2	25,8	1,2	1
Minyak	902	0	0	100	1
Gula	364	0	94	0	1

Sumber: (Mufida et al., 2022)

Nutrisi tambahan diperlukan oleh ibu menyusui untuk membuat ASI dan menyimpannya dalam ASI mereka sendiri. perlu mengembalikan kesehatannya setelah melahirkan. Efek negatif dari asupan makanan yang tidak mencukupi termasuk produksi ASI yang lebih buruk karena kondisi kesehatan dan gizi ibu. (Wardani et al., 2021).

H. Panduan Makanan Bagi Ibu Menyusui

Panduan makanan guna ibu menyusui adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah, sayur, protein, biji-bijian, dan susu (Wardani et al., 2021).

1. Buah dan sayur

- Konsumsi 3 porsi buah dan sayur setiap hari
- Pilih buah berwarna terang dan sayuran berwarna hijau
- Contoh buah dan sayur yang bisa dikonsumsi: alpukat, brokoli, bayam, kentang, tomat

2. Protein

- a. Konsumsi 3 porsi protein tanpa lemak setiap hari
- b. Sumber protein yang baik: telur, ikan, tempe, daging, tempe

3. Biji-bijian

- a. Konsumsi minimal 4 porsi biji-bijian setiap hari
- b. Contoh biji-bijian: gandum dan kacang-kacangan

4. Susu

- a. Konsumsi minimal 2 gelas susu per hari
- b. Susu mengandung kalsium, lemak, dan protein
- c. Produk olahan susu, layaknya yoghurt serta keju, juga baik untuk dikonsumsi

5. Makanan lain

- a. Gandum utuh, Nasi merah, Ikan salmon, Air daun katuk, Kacang almond, Ubi jalar, Kurma.
- b. Minuman Batasi asupan kopi hingga 2–3 cangkir per hari, Hindari minuman beralkohol.

6. Pola makan

- c. Hindari makanan dan minuman yang tidak memiliki nutrisi, protein, dan kalori
- d. Jika pola makan menyebabkan asupan satu atau lebih zat gizi rendah, pertimbangkan suplementasi zat gizi

I. Penutup

Gizi ibu nifas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena mempengaruhi kesejahteraan khususnya ibu dan bayi. Kecukupan nutrisi ibu menyusui bisa dilihat dari produksi ASI yang dihasilkannya. Kekurangan nutrisi ibu menyusui akan berdampak juga pada dirinya dan bayi seperti berat badan lahir bayi yang tidak mengalami peningkatan, risiko penyakit menular, serta hambatan pertumbuhan dan keterlambatan perkembangan pada anak. Nutrisi yang cukup selama menyusui sangat krusial guna memastikan kesehatan yang baik pada ibu serta bayinya.

Kurangnya kesadaran akan asupan nutrisi yang dibutuhkan saat menyusui adalah masalah umum yang dihadapi oleh ibu menyusui. Kesehatan ibu dan anak dapat dipengaruhi oleh nutrisi. Mempertahankan pola makan yang sehat berkaitan dengan harapan hidup yang lebih panjang, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan kemungkinan terkena penyakit degeneratif yang lebih rendah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, prinsip dasar dari kepuasan nutrisi adalah mengonsumsi

berbagai jenis makanan dalam proporsi yang seimbang. Asupan nutrisi harian biasanya meningkat untuk semua ibu menyusui. Masalah gizi jangka panjang dapat mengubah beberapa komponen dalam ASI, meskipun ibu yang memiliki masalah gizi masih bisa melakukan produksi ASI.

Referensi

- Carretero-Krug, A., Montero-Bravo, A., Morais-Moreno, C., Puga, A. M., Samaniego-Vaesken, M. de L., Partearroyo, T., & Varela-Moreiras, G. (2024). Nutritional Status of Breastfeeding Mothers and Impact of Diet and Dietary Supplementation: A Narrative Review. *Nutrients*, 16(2), 1–28. <https://doi.org/10.3390/nu16020301>
- Fatimah, Rahma Delia, A., Nurdyanah, & Damayanti, T. (2022). *ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, BBL DAN KB*. CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Hidayatunnikmah, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Ekonomi Ibu Menyusui Terhadap Kualitas Komponen Makronutrien Asi. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.24929/jik.v4i2.796>
- Kakiay, A., & Wigiyanti. (2022). Jurnal Riset Ilmiah. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18.
- KEMENKES. (2020). *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*. 9–12.
- Mufida, R. T., Rohmah, M., & Wungo, P. (2022). Analisis Ibu menyusui terhadap Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v5i1.90>
- Nikmah, N., & Anggraeni, N. (2023). Upaya Menjaga Nutrisi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, 3(01), 24. <https://doi.org/10.30587/ijcdh.v3i01.4608>
- Rahmawati, A. (2020). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan. *Perawat Indonesia*, 4(2), 351–356.
- Suciati, S., & Wulandari, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan*, 10(2), 1–6. <https://journal.unita.ac.id/index.php/bidan/article/view/406>
- Taqiyah, Y., Iftitah Alam, R., & Jama, F. (2022). Edukasi Kebutuhan Gizi Seimbang pada Ibu Menyusui di Ruang Nifas RSUD Ibnu Sina Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat*, 2(1), 5–8.
- Wardani, Y. S., Megawati, G., & Herawati, D. M. D. (2021). Asupan Gizi Dan Pola Makan Ibu Menyusui Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Ibrahim Aji Kota Bandung. *Gizi Indonesia*, 44(1), 65–76. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v44i1.456>
- Wati, S. K., Kusyani, A., & Fitriyah, E. T. (2021). Pengaruh faktor ibu (pengetahuan ibu ,

pemberian ASI- eksklusif & MP-ASI) terhadap kejadian stunting pada anak.
Journal of Health Science Community, 2(1), 13.

Glosarium

E

Early ambulation adalah kegiatan bergerak bebas dan teratur yang dilakukan segera setelah operasi atau melahirkan

Edema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan di jaringan atau organ tubuh

P

Post Partum : masa setelah melahirkan atau persalinan

Predlo urine : Kesulitan Berkemih

U

Uretra yakni saluran yang mempunyai fungsi mengeluarkan urine dari kandung kemih ke luar tubuh

BAB II

MAKANAN YANG MENDUKUNG PRODUKSI ASI

A. Pendahuluan

Banyak di antara ibu menyusui yang merasa khawatir tentang kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terutama dalam memproduksi Air Susu Ibu (ASI) yang cukup bagi bayinya. ASI yang tidak mencukupi sering disebut sebagai alasan untuk menghentikan menyusui dan suplementasi. Dalam menangani masalah ini, sangat penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan pengaruh kesehatan ibu dan bayi baru lahir, isapan bayi, pelekatan yang benar, dan frekuensi menyusui terhadap produksi ASI, dan langkah apa harus diambil untuk memperbaiki atau mengimbangi faktor-faktor ini (Foong et al., 2020).

Produksi ASI yang optimal sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Namun, banyak ibu menyusui menghadapi tantangan dalam menghasilkan ASI yang cukup, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, kelelahan, dan asupan nutrisi yang tidak memadai. Salah satu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI adalah melalui konsumsi makanan sehat yang memiliki efek laktagogum, yaitu kemampuan untuk merangsang produksi ASI (Ramadhani et al., 2023).

Menyusui telah lama dikenal sebagai metode alami yang memberikan nutrisi optimal bagi bayi serta memberikan manfaat kesehatan jangka panjang bagi ibu dan anak. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi selama abad ke-20 telah berdampak signifikan pada praktik menyusui di seluruh dunia. Sejak berkembangnya industri susu formula pada pertengahan abad ke-20, angka menyusui mengalami penurunan drastis, terutama di negara-negara maju. Banyak faktor yang memengaruhi tren ini, termasuk urbanisasi, meningkatnya jumlah ibu bekerja, pemasaran agresif susu formula, serta perubahan norma sosial mengenai pola asuh anak. Akibatnya, banyak bayi tidak mendapatkan manfaat penuh dari ASI, yang secara ilmiah terbukti melindungi mereka dari infeksi, malnutrisi, dan penyakit kronis di kemudian hari (Prentice, 2022).

Angka menyusui di Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase bayi berusia di bawah 6 bulan yang menerima ASI eksklusif mencapai 73,97% pada tahun 2023, meningkat dari 72,04% pada tahun 2022 (Annur, 2024). Namun, data dari Survei Kesehatan

Nasional (SKI) 2023 menunjukkan bahwa hanya 27% bayi baru lahir yang menerima ASI dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Selain itu, satu dari lima bayi diberi makanan atau cairan selain ASI dalam tiga hari pertama kehidupannya, dan hanya 14% yang mengalami kontak kulit ke kulit setidaknya selama satu jam segera setelah lahir (Unicef, 2024).

Secara global, studi menunjukkan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI memiliki risiko meninggal sebelum usia satu tahun hingga 14 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang disusui secara eksklusif selama enam bulan pertama. Selain itu, terdapat bukti bahwa anak-anak yang disusui cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dalam tes kecerdasan, dengan peningkatan IQ sekitar 3 hingga 4 poin, lebih jarang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, serta memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes di masa depan. Lebih dari 820.000 anak di bawah usia lima tahun dapat diselamatkan setiap tahun jika mendapatkan ASI yang optimal. Pemberian ASI juga dapat mencegah 20.000 kasus kanker payudara pada wanita setiap tahunnya. (Unicef, 2024).

Bayi pada enam bulan pertama kehidupannya menerima banyak nutrisi dari air susu ibu. Termasuk protein, lemak sehat, mineral, dan vitamin, ASI mengandung berbagai zat gizi penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, ibu menyusui harus memastikan bahwa kualitas dan jumlah ASI yang mereka produksi tetap terjaga. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi ASI adalah asupan nutrisi ibu.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan tertentu dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Makanan ini sering disebut sebagai "galactagogue" atau makanan pelancar ASI, seperti daun katuk, bayam, oatmeal, kacang-kacangan, dan makanan yang kaya protein dan lemak, memiliki zat gizi dan bahan aktif yang dapat merangsang hormon prolaktin dan oksitosin, yaitu dua hormon utama yang bertanggung jawab untuk produksi ASI. Selain itu, pola makan seimbang dan hidrasi yang cukup juga sangat penting. Dalam bab ini, kita akan membahas berbagai jenis makanan yang terbukti dapat meningkatkan produksi ASI berdasarkan sumber ilmiah.

B. Makanan Pelancar Produksi ASI

Selama masa laktasi, komposisi ASI berubah dari kolostrum menjadi susu transisi hingga susu matur. Kolostrum merupakan cairan pertama yang diproduksi oleh ibu setelah melahirkan dalam jumlah sedikit selama dua hingga empat hari pertama setelah melahirkan. Kolostrum berbeda dari susu matur dalam hal warna, komposisi, dan konsistensi. Meskipun nutrisi dalam kolostrum dan susu matur tetap

sama, kadar nutrisinya bervariasi selama masa laktasi. Kolostrum kaya akan protein whey dan mineral, namun, kolostrum mengandung kadar laktosa dan lemak serta vitamin tertentu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan susu matur. Meskipun memiliki kadar klorida, natrium, dan magnesium yang lebih tinggi, kolostrum memiliki kadar kalsium dan kalium yang lebih rendah jika dibandingkan dengan susu matur (Lyons et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Foong et al (2020), merupakan tinjauan sistematis yang mengevaluasi efektivitas galaktagog oral, baik farmakologis maupun alami, dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui dengan bayi cukup bulan yang tidak dirawat di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa galaktagog farmakologis memiliki kemampuan untuk meningkatkan volume ASI. Nilai perbedaan rata-rata (MD) adalah 63,82 mililiter, *Confidence Interval* (CI) 95% adalah 25,91 hingga 101,72. Namun, tidak ada perbedaan signifikan dalam penambahan berat badan bayi yang hanya menerima ASI dari ibunya (MD 23,0 gram, 95% CI -47,71 hingga 93,71). Tidak ada laporan efek samping pada bayi, namun ibu mengalami kelelahan, mual, sakit kepala, dan mulut kering.

Sebanyak 27 penelitian mempelajari galaktagog alami seperti fenugreek (kelabat), jahe, moringa, adas, bunga/jantung pisang, dan lainnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa berat badan dan volume ASI bayi meningkat, tetapi studi-studi tersebut sangat berbeda sehingga sulit untuk melakukan meta-analisis. Efek samping yang dilaporkan pada ibu termasuk perut kembung dan bau urin seperti sirup maple, sementara pada bayi termasuk mual dan urtikaria (Foong et al., 2020).

Banyak generasi wanita di seluruh dunia telah menggunakan berbagai macam galaktagog alami untuk meningkatkan produksi ASI. Rempah-rempah dan makanan adalah bagian penting dari perawatan kesehatan dalam banyak budaya tradisional. Untuk memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup, ibu-ibu baru biasanya diberi makanan atau minuman khusus. Di Filipina dan di beberapa bagian Afrika dan India, hidangan yang mengandung moringa dijual sebagai profilaksis maupun sebagai pengobatan untuk produksi ASI yang rendah. Di sisi lain, orang Eropa lebih cenderung menggunakan rebusan galaktagog dan menyeduh infus teh untuk mengobati produksi ASI yang rendah, daripada untuk profilaksis (Bruckner 1993 dalam Foong et al, (2020). Studi yang dilakukan oleh Yuniartis (2023), melihat bagaimana galaktagog alami dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu nifas. Penelitian melalui tinjauan literatur ini menemukan bahwa fenugreek, biskuit daun katuk, adas, jahe, teh herbal Wang Nam Yen, barley malt, dan jus kelakai adalah galaktagog alami yang dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu nifas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al (2023), bertujuan untuk mengidentifikasi makanan sehat yang dapat memperlancar produksi Air Susu Ibu (ASI). Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis 10 artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar, menggunakan kata kunci "makanan sehat" dan "produksi ASI". Dari analisis tersebut, ditemukan lima jenis makanan yang berpotensi meningkatkan produksi ASI:

1. **Buah Pepaya:** Mengandung laktagogum, termasuk alkaloid, polifenol, flavonoid, dan steroid, yang memiliki kemampuan untuk merangsang hormon oksitosin dan prolaktin, yang dapat meningkatkan produksi ASI.
2. **Daun Katuk:** Mengandung banyak alkaloid dan sterol yang berperan sebagai galactagogue. Daun katuk dapat merangsang peningkatan produksi ASI melalui peningkatan kadar hormon prolaktin.
3. **Daun Kelor:** Mengandung alkaloid, flavonoid, fitosterol, dan saponin, yang memiliki kemampuan untuk merangsang produksi ASI melalui pengaktifan hormon prolaktin.
4. **Kacang Hijau:** Kaya akan protein, zat besi, dan vitamin B1 yang dapat meningkatkan produksi ASI melalui peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin. Hasil penelitian Mirani (2024), menunjukkan bahwa produksi ASI dapat meningkat dengan pemberian sari kacang hijau. Rata-rata produksi ASI sekitar 7,06 sebelum ibu menyusui diberikan sari kacang hijau, sedangkan yang diberikan sari kacang hijau adalah 10,63.
5. **Ubi Jalar Ungu:** Mengandung protein dan zat besi yang mendukung produksi ASI yang optimal, serta polifenol yang mempengaruhi peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Handayani et al (2021), mengkaji penggunaan tanaman lokal oleh masyarakat desa dalam memperlancar produksi Air Susu Ibu (ASI). Studi ini melibatkan 123 ibu yang memiliki bayi/anak di bawah 2 tahun sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan beberapa jenis tanaman lokal sebagai galaktagogue, yaitu:

1. Daun katuk (*Sauropus androgynus*) digunakan oleh Sebagian responden (50,4%)
2. Daun kelor (*Moringa oleifera*) dimanfaatkan oleh 38,2% responden.
3. Daun turi (*Sesbania grandiflora*) digunakan oleh 8,9% responden.
4. Bayam (*Amaranthus spp.*) dimanfaatkan oleh 2,4% responden.\

Semua tanaman tersebut diolah dengan cara disayur bening sebelum dikonsumsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tanaman lokal tersebut dapat mempercepat produksi ASI.

Penelitian yang dilakukan oleh Delvina et al (2022), bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI pada ibu menyusui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berhubungan signifikan dengan produksi ASI, salah satu diantaranya adalah faktor asupan nutrisi ibu. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa ibu yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang cenderung memiliki produksi ASI yang lebih baik.

Lokossou et al (2022), mengkaji peran ASI tidak hanya sebagai sumber nutrisi, tetapi juga sebagai komponen penting dalam respons imun yang memberikan perlindungan terhadap penyakit bagi bayi dan ibu. Studi ini menyoroti bahwa ASI mengandung berbagai komponen bioaktif, termasuk antibodi, sel imun, sitokin, dan faktor pertumbuhan, yang berkontribusi pada pengembangan sistem kekebalan bayi dan menawarkan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, menyusui juga memberikan manfaat imunologis bagi ibu, seperti penurunan risiko kanker payudara dan ovarium.

Banyak studi atau penelitian yang membahas tentang makanan sumber ASI yang baik. Salah satu studi literatur bertujuan untuk menemukan bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai galaktogog atau pelancar ASI, dengan melakukan tinjauan literatur terhadap enam jurnal terkait. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa beberapa tanaman di Indonesia diyakini dapat meningkatkan produksi ASI. Beberapa di antaranya telah diidentifikasi sebagai galaktogog dalam obat herbal asli Indonesia pada tahun 2016, termasuk (Oktiningrum et al., 2023).

1. Daun katuk (*Sauropus androgynus*): Mengandung senyawa yang dapat merangsang produksi ASI.
2. Biji klabat (*Trigonella foenum-graceum*): Dikenal memiliki efek positif dalam meningkatkan produksi ASI.
3. Daun jinten atau torbangun (*Coleus amboinicus*): Digunakan secara tradisional untuk memperlancar ASI.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tanaman lain yang secara ilmiah dapat digunakan sebagai pelancar ASI, seperti jantung pisang (*Musa paradisiaca*), daun turi (*Sesbania grandiflora*), dan daun kelor (*Moringa oleifera*). Tanaman-tanaman tersebut mudah ditemukan di Indonesia dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui (Oktiningrum et al., 2023).

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa daun kelor mengandung senyawa fitosterol yang diduga dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin, yang berperan penting dalam produksi ASI. Konsumsi daun kelor, baik dalam bentuk ekstrak, kapsul, maupun olahan makanan seperti puding, dapat membantu ibu menyusui menghasilkan lebih banyak ASI (Nurillah & Yuniarti, 2023).

Penggunaan bahan alami diyakini sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi ASI. Selain mudah didapat, penggunaan bahan alami ini dapat mengurangi ketergantungan pada obat-obatan yang mungkin mempengaruhi kualitas ASI. Namun, disarankan agar ibu menyusui tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen atau ramuan tertentu untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya (Oktiningrum et al., 2023).

Berbagai referensi yang sudah tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh Anju et al (2022), mengkaji berbagai penggunaan tradisional dari tanaman *Sauropus androgynus* (L.) Merr., yang dikenal sebagai daun katuk, dalam kuliner etnis dan persiapan etnomedisinal di berbagai komunitas. Studi ini mengidentifikasi bahwa daun katuk merupakan sumber kaya nutrisi mikro dan makro, serta mengandung berbagai senyawa bioaktif. Penggunaan kuliner tradisional daun katuk meliputi berbagai hidangan di komunitas etnis, sementara dalam praktik etnomedisinal, daun ini digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, penelitian ini menekankan perlunya studi lebih lanjut terkait aspek keamanan konsumsi daun katuk, mengingat informasi mengenai toksisitasnya masih terbatas.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya investigasi lebih lanjut untuk memahami komposisi nutrisi, kandungan fitokimia, dan dasar farmakologis dari penggunaan etnomedisinal daun katuk. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya dalam konteks kuliner dan pengobatan tradisional. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa *Sauropus androgynus* memiliki potensi besar dalam aplikasi kuliner dan medis tradisional, namun diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami profil toksisitas dan memastikan penggunaannya aman bagi kesehatan (Anju et al., 2022).

Referensi lain menyebutkan bahwa daun kelakai berpengaruh terhadap peningkatan produksi ASI, terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Grasiana et al (2023), yang mengevaluasi efek konsumsi puding daun kelakai terhadap produksi ASI dan kadar hemoglobin pada ibu menyusui. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan volume ASI dan kadar hemoglobin setelah intervensi. Sebelum perlakuan, 80% partisipan memiliki volume ASI sekitar 50-100 ml, yang

meningkat menjadi >100 ml pada 30% partisipan setelah tujuh hari. Volume ASI rata-rata meningkat dari 63 ml menjadi 102,25 ml pada hari ketujuh sebelum intervensi. Selain itu, kadar hemoglobin normal meningkat dari 65% sebelum intervensi menjadi 95% setelah tujuh hari, dengan rata-rata kadar hemoglobin meningkat dari 12,64 g/dl menjadi 14,16 g/dl. Senyawa-senyawa alami yang terkandung dalam daun kelakai membantu meningkatkan pengeluaran hormon untuk memproduksi ASI.

Sebuah studi dengan tinjauan literatur review yang dilakukan oleh Ariyanti et al (2023), ditemukan bahwa konsumsi jahe selama masa menyusui dapat meningkatkan produksi ASI. Jahe mengandung senyawa aktif seperti 6-gingerol dan 10-gingerdione, yang berfungsi sebagai galaktagog, yang diyakini dapat merangsang hormon prolaktin, yang bertanggung jawab atas produksi ASI. Selain itu, jahe memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi, yang dapat meningkatkan kesehatan ibu menyusui secara keseluruhan, sehingga berpotensi meningkatkan produksi ASI.

Selain referensi di atas, busui dapat mengonsumsi beberapa jenis makanan berikut untuk meningkatkan produksi ASI:

1. Susu Kedelai dan Almond

Sebuah studi kasus dengan perlakuan pada 2 ibu menyusui. Seorang ibu diberikan susu kedelai, sementara subjek lainnya menerima susu almond. Setelah intervensi, kedua ibu menyusui menunjukkan peningkatan produksi ASI. Observasi lebih lanjut mengindikasikan bahwa susu kedelai memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan produksi ASI dibandingkan dengan susu almond.

Susu almond dan susu kedelai keduanya dapat meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, tetapi susu kedelai menunjukkan peningkatan ASI yang lebih besar dalam meningkatkan produksi. Penemuan ini dapat dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan saat mereka membuat rekomendasi nutrisi untuk membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui (Haryani & Hidayani, 2024). Selain itu, kombinasi almond dan kelor dalam bentuk smoothies dapat berperan sebagai nutrisi tambahan yang efektif untuk meningkatkan produksi ASI (Oktafiani et al., 2022).

2. Alpukat

Alpukat mengandung banyak nutrisi yang diperlukan ibu selama menyusui, termasuk serat, protein, karbohidrat, lemak tak jenuh tunggal, mineral dan vitamin, yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Sebuah inovasi baru, Jus Alpukat dan Kurma sebagai Booster ASI menggabungkan alpukat dan kurma untuk meningkatkan produksi ASI.

Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan produksi ASI tetapi juga membantu menjaga kesehatan ibu menyusui, mencegah kelelahan, memperkuat tulang, dan mencegah kegemukan (Erizqianova et al., 2023).

3. Jantung Pisang

Penelitian menunjukkan bahwa baik kacang hijau maupun jantung pisang bisa membantu melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui, namun ternyata jantung pisang lebih efektif. Dalam sebuah studi dengan 30 ibu menyusui, setengah dari mereka mengonsumsi kacang hijau dan setengah lagi makan jantung pisang. Hasilnya, kelompok yang mengonsumsi jantung pisang mengalami peningkatan produksi ASI yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kacang hijau. Jantung pisang lebih efektif melancarkan produksi ASI karena kandungan nutrisinya yang bisa merangsang produksi ASI lebih baik daripada kacang hijau. Di sisi lain, kacang hijau juga punya banyak nutrisi penting seperti protein dan vitamin yang membantu, tapi efeknya nggak sebesar jantung pisang (Fatin & Rizki, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Joharmi et al (2020) dan Astari & Hardianti (2022), didapatkan bahwa setelah mengonsumsi jantung pisang, produksi ASI ibu-ibu menyusui meningkat secara signifikan. Studi ini menemukan bahwa jantung pisang yang telah diolah mengandung zat-zat seperti steroid, alkaloid, flavonoid, dan polifenol, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin dan prolaktin, yaitu hormon yang sangat penting untuk produksi ASI. Untuk ibu yang baru melahirkan, disarankan untuk mengonsumsi jantung pisang yang telah diolah sebagai alternatif alami untuk meningkatkan produksi ASI.

C. Contoh Menu Harian Untuk Ibu Menyusui yang Mendukung Produksi ASI

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa cara mengolah makanan yang mendukung produksi ASI (Adur et al., 2025; Fatin & Rizki, 2019; Mirani, 2024):

1. Sayuran Hijau (daun katuk, daun kelor, bayam, brokoli): Dapat diolah dengan merebus atau mengukus sayuran hijau untuk mempertahankan nutrisi. Untuk meningkatkan asupan harian, campurkan sayuran hijau dalam sup atau salad.
2. Buah pepaya dikenal dapat membantu meningkatkan produksi ASI karena mengandung enzim, vitamin A, C, dan E, serta mineral yang baik untuk ibu menyusui. Pengolahan buah pepaya untuk meningkatkan ASI bisa dengan membuat jus pepaya, sup pepaya muda, salad pepaya matang, dan juga olahan smoothie pepaya dengan oatmeal.

3. Gandum dan Oatmeal: pengolahannya dengan cara memasak oatmeal atau gandum utuh dengan air atau susu hingga matang. Untuk rasa yang lebih enak, tambahkan sedikit madu dan buah segar seperti pisang atau stroberi. Oat dapat meningkatkan ASI karena kandungan serat dan zat besi yang ada di dalamnya.
Kacang-Kacangan (Kacang hijau, kedelai, kacang merah, almond, kenari): Kacang-kacangan dapat diolah menjadi pasta, ditambahkan ke salad, atau dijadikan camilan sehat. Kacang merah juga dapat direbus dan dicampur dengan sup atau hidangan utama. Adapun cara mengolah kacang hijau sangat sederhana, seperti membuat bubur kacang hijau, susu kacang hijau, smoothie kacang hijau dan pisang, tumis tauge kacang hijau, bakso kacang hijau, dan juga pudding kacang hijau.
4. Biji-Bijian (Wijen, Biji Chia, Biji Rami, biji labu): Untuk meningkatkan asupan nutrisi, campurkan biji-bijian ini ke dalam smoothie, sereal, atau yogurt.
5. Puding Kacang Hijau: Rendam kacang hijau semalaman dengan air dan santan. Kemudian masak hingga matang, tambahkan gula sesuai selera, dan sajikan sebagai snack sehat.
6. Ubi Jalar: Panggang atau rebus ubi jalar hingga empuk. Ubi jalar bisa dikonsumsi sebagai lauk pendamping nasi atau dihaluskan menjadi puree. Pengolahan lainnya seperti membuat kolak ubi ungu, smoothie ubi, sup krim ubi, bola ubi isi keju, pudding ubi, dan juga keripik ubi.
7. Ikan dan Telur: Masak ikan dengan cara dipanggang atau dikukus. Pastikan ikan matang sepenuhnya. Untuk meningkatkan protein, rebus telur atau buat omelet dengan sayuran.
8. Jantung pisang: dapat dimasak dengan cara membuat tumisan jantung pisang, sayur lodeh, perkedel jantung pisang. Menurut beberapa penelitian, jantung pisang mengandung banyak nutrisi seperti serat, fosfor, kalsium, protein, dan zat besi, serta kandungan laktagogum, yang dapat merangsang produksi ASI.
9. Bawang Putih: Ikan dan Telur: Masak ikan dengan cara dipanggang atau dikukus. Pastikan ikan matang sepenuhnya untuk keamanan. Telur bisa direbus atau dibuat omelet dengan sayuran untuk meningkatkan kandungan protein

D. Peran Asuhan Kebidanan Komplementer dalam Meningkatkan Produksi ASI

Sebuah studi literatur yang bertujuan untuk mengevaluasi peran asuhan kebidanan komplementer dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, menganalisis sebanyak 30 jurnal dengan hasil menunjukkan bahwa metode alami, seperti penggunaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), akupresur, akupunktur, dan pijat, dapat membantu ibu meningkatkan produksi ASI. Pendekatan ini bisa menjadi

alternatif yang aman dan bermanfaat bagi ibu yang mengalami kesulitan dalam memproduksi ASI. Namun, sebelum mencoba terapi ini, sebaiknya ibu menyusui berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan. Tujuannya biar lebih aman dan memastikan metode yang dipilih benar-benar cocok dan efektif sesuai kondisi masing-masing. Dengan begitu, ibu bisa merasa lebih tenang dan percaya diri dalam memberikan ASI untuk si kecil. Yuliani et al (2022),

Sebagai tenaga kesehatan, bidan juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada para kader, komunitas, dan keluarga. Ini akan sangat membantu mereka menyelesaikan masalah dan mendukung ibu menyusui yang menghadapi masalah dalam pemberian ASI Eksklusif karena ASI tersumbat/tidak lancar. Ini membuat busui lebih percaya diri dan semangat untuk memberikan ASI. Adapun cara untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan mengonsumsi olahan makanan termasuk oatmeal, bawang putih, dan jahe. Selain itu, jenis sayuran seperti ubi jalar, daun katuk, daun kelor, dan daun papaya muda, mengandung banyak provitamin A dan protein yang dapat meningkatkan pasokan ASI. Selain faktor makanan, Faktor-faktor seperti ketenangan jiwa, penggunaan alat kontrasepsi, kondisi psikologis, pola istirahat, isapan bayi atau frekuensi menyusui, berat lahir bayi, usia kehamilan saat melahirkan, dan konsumsi rokok atau alkohol dapat memengaruhi produksi ASI (Yuliawati et al., 2023).

Bidan punya peran yang sangat penting dalam mendukung ibu-ibu yang mengalami masalah dengan kelancaran ASI, terutama dalam pemberian ASI eksklusif. Sebagai tenaga kesehatan, bidan bukan hanya membantu secara medis, tapi juga memberikan edukasi dan dukungan emosional. Berikut beberapa peran bidan dalam hal ini (Yuliawati et al., 2023):

1. **Memberikan Penyuluhan:** Bidan bisa ngadain penyuluhan buat para kader, keluarga, dan masyarakat biar mereka paham pentingnya ASI eksklusif. Misalnya, menjelaskan manfaat ASI bagi ibu dan bayi, posisi menyusui yang benar, atau makanan apa aja yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI, dan cara mengolah makanan tersebut.
2. **Konseling Laktasi:** Bidan dapat memberikan konseling laktasi secara langsung kepada ibu yang mengalami masalah, seperti bayi yang kesulitan menyusu atau ASI seret. Dukungan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu dan mendorong mereka untuk terus menyusui.
3. **Saran Makanan yang Membantu Produksi ASI:** Bidan bisa merekomendasikan makanan yang membantu meningkatkan produksi ASI, seperti jantung pisang, daun katuk, atau oatmeal.

4. **Membangun Dukungan dari Keluarga:** Bidan bisa mengedukasi keluarga agar lebih mendukung ibu menyusui. Misalnya membantu pekerjaan rumah atau memberikan motivasi secara emosional, agar ibu tidak stres dan bisa fokus menyusui bayinya.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Bidan dapat terus memantau perkembangan produksi ASI dan kondisi bayi, serta membantu memecahkan masalah jika ada, seperti masalah dalam hal menyusui seperti masalah bayi kurang berat badan atau teknik menyusui yang kurang tepat.

E. Penutup

Makanan yang mendukung produksi ASI sangat dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi ibu selama menyusui. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI diperlukan diet seimbang yang kaya akan makanan yang mendukung produksi ASI. Karena setiap ibu menyusui itu unik, dan respons terhadap makanan tertentu dapat berbeda-beda. Maka sangat penting bagi ibu menyusui untuk menyesuaikan diet sesuai dengan kebutuhan.

Dari berbagai penelitian yang dibahas dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa makanan tertentu mempunyai peran penting dalam mendukung produksi ASI. Beberapa jenis makanan, seperti jantung pisang, papaya, daun katuk, daun kelor, oatmeal, dan kacang-kacangan terbukti dapat membantu merangsang hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan dalam produksi dan pengeluaran ASI. Selain itu, mengonsumsi makanan dengan kandungan protein, lemak sehat, zat besi, dan vitamin yang seimbang juga bisa meningkatkan kualitas dan jumlah ASI. Metode alami seperti penggunaan Tanaman Obat Keluarga, pijat laktasi, dan akupresur, juga menunjukkan hasil yang baik dalam membantu memperlancar ASI.

Makanan laktogenik atau ASI booster adalah makanan yang dibuat atau diolah untuk meningkatkan produksi ASI ibu menyusui. Makanan ini mengandung galaktagog, yaitu senyawa pada tanaman yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau merangsang produksi ASI ibu menyusui. Beberapa contoh makanan yang membantu produksi ASI adalah:

1. Sayuran hijau: Daun katuk, daun kelor, bayam, brokoli
2. Kacang-kacangan: kacang hijau, kedelai, almond
3. Biji-bijian: biji chia, biji rami (flaxseed), biji labu
4. Buah-buahan: papaya, ubi ungu, alpukat, kurma
5. Protein hewani: salmon, telur, daging tanpa lemak
6. Gandum utuh: oatmeal, roti gandum
7. Jantung pisang

8. Makanan pendukung lainnya: bawang putih, jahe, air putih

Petugas kesehatan perlu berperan proaktif dalam mendukung ibu menyusui mengatasi masalah produksi ASI, termasuk ASI sedikit atau kurang lancar. Banyak ibu yang akhirnya berhenti memberikan ASI eksklusif karena minimnya pengetahuan serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan yang menganggap susu formula lebih unggul daripada ASI. Kesimpulannya, kombinasi antara asupan makanan yang tepat dan dukungan emosional yang baik bisa sangat membantu ibu menyusui dalam memenuhi kebutuhan ASI untuk bayinya secara optimal.

Bab ini menekankan betapa pentingnya mendukung produksi ASI melalui makanan yang tepat dan pola hidup sehat bagi ibu menyusui. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi sangat dianjurkan karena dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi melalui penyediaan nutrisi yang optimal.

Sebelumnya, kita telah membahas beragam jenis makanan laktogenik yang dapat mendukung peningkatan produksi ASI, seperti sayuran hijau, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Beberapa dari makanan ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas ASI, sehingga bayi bisa memperoleh semua nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu, kesehatan mental dan fisik ibu merupakan salah satu faktor penting bagi ibu agar terhindar dari stres dan kecemasan yang berdampak pada produksi ASI. Sehingga sangat disarankan agar ibu mendapat dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar selama proses menyusui. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan setiap ibu dapat memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka. Setiap tetes ASI yang diberikan merupakan investasi berharga bagi masa depan generasi penerus.

Seluruh pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi ibu menyusui dalam Upaya meningkatkan produksi ASI. Sehingga semua ibu masa laktasi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi terbaik bagi bayinya selama periode penting perkembangan awal mereka, dengan memahami faktor apa saja berpengaruh terhadap produksi ASI dan menerapkan pola hidup sehat.

Referensi

- Adur, Y. A., Destriani, P., Jelu, Y. P., & Manggul, M. S. (2025). Edukasi Pemanfaatan Puding kacang Hijau Untuk Meningkatkan Produksi ASI di Desa Lolang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Inovatif*, 8, 9–14.
- Anju, T., Rai, N. K. S. R., & Kumar, A. (2022). Sauropus androgynus (L.) Merr.: a multipurpose plant with multiple uses in traditional ethnic culinary and ethnomedicinal preparations. *Journal of Ethnic Foods*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s42779-022-00125-8>
- Annur, C. M. (2024). *Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif di Indonesia Kembali Meningkat pada 2023*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/372882ee9d3db2c/persentase-bayi-yang-mendapat-asi-eksklusif-di-indonesia-kembali-meningkat-pada-2023#:~:text=Persentase bayi ASI eksklusif nasional,ASI eksklusif terjadi sejak 2019.>
- Ariyanti, R., Permatasari, A. E., & Umami, N. (2023). Galaktogue pada Jahe dapat Meningkatkan Produksi ASI: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(2), 639–644. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.956>
- Astari, R. Y., & Hardianti, V. (2022). Pengaruh Konsumsi Olahan Jantung Pisang terhadap Peningkatan Produksi Air Susu Ibu pada Ibu Postpartum. *Faletehan Health Journal*, 9(02), 234–239. <https://doi.org/10.33746/fhj.v9i02.269>
- Delvina, V., Kasoema, R. S., & Fitri, N. (2022). Faktor yang Berhubungan Dengan Produksi Air Susu Ibu (ASI) pada Ibu Menyusui. *Human Care Journal*, 7(1), 153–164.
- Erizqianova, Kholilah, Cahyaningtiyas, D., Prihati, M., & Indriyani, T. (2023). Peranan Jus Alpukat Dan Kurma Sebagai Booster Asi Pada Ibu Hamil Dan Menyusui Di Tpm N Jakarta Barat. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 5(4), 1317–1322. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Fatrin, T., & Rizki, K. (2019). Perbandingan Efektifitas Pemberian Kacang Hijau dan Jantung Pisang terhadap Kelancaran Produksi ASI Ibu Menyusui. *Cendikia Medika*, 4(2), 129–138.
- Foong, S. C., Tan, M. L., Foong, W. C., Marasco, L. A., Ho, J. J., & Ong, J. H. (2020). Oral Galactagogues (Natural Therapies or Drugs) for Increasing Breast Milk Production in Mothers of Non-Hospitalised Term Infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011505.pub2>
- Grasiana, G., Endah Wahyutri, Nilam Noorma, & Grace Carol Sipasulta. (2023). Pengaruh

- Konsumsi Puding Daun Kelakai terhadap Peningkatan Produksi ASI dan Kadar Hemoglobin pada Ibu Menyusui di Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Besiq. *Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR)*, 6(2), 64–73. <https://doi.org/10.35473/ijnr.v6i2.2291>
- Handayani, S., Pratiwi, S. Y., & Fatmawati, N. (2021). Memperlancar Asi 7. *Jurnal Kebidanan*, 518–522.
- Haryani, D., & Hidayani. (2024). *Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Menyusui Melalui Pemberian Susu Almond dan Susu Kedelai di Wilayah Kerja Puskesmas Pagelaran Tahun 2024*. 4, 97–101.
- Joharmi, Atika, & Juliana. (2020). *Pengaruh konsumsi jantung pisang terhadap peningkatan produksi asi pada ibu nifas di klinik Murniati Kisaran*. XIII(01), 155–162.
- Lokossou, G. A. G., Kouakanou, L., Schumacher, A., & Zenclussen, A. C. (2022). Human Breast Milk: From Food to Active Immune Response With Disease Protection in Infants and Mothers. *Frontiers in Immunology*, 13, 849012. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.849012>
- Lyons, K. E., Ryan, C. A., Dempsey, E. M., Ross, R. P., & Stanton, C. (2020). Breast milk, a source of beneficial microbes and associated benefits for infant health. *Nutrients*, 12(4), 1–30. <https://doi.org/10.3390/nu12041039>
- Mirani, N. (2024). Pengaruh Pemberian Sari Kacang Hijau Terhadap Produksi ASI Pada Ibu Menyusui. *Sinar: Jurnal Kebidanan*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.30651/sinar.v6i1.21970>
- Nurillah, N., & Yuniarti, E. (2023). Literature Review: Efektivitas Daun Kelor Morinaga Oleifera Terhadap Produksi Air Susu Ibu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(2), 308–316. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i2.2573>
- Oktafiani, H., Sari, D. N., & Valiani, C. (2022). Smoothies Almond Kelor sebagai Nutrisi Tambahan Ibu Nifas untuk Meningkatkan Kuantitas Air Susu Ibu. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 9(2), 131–137. <https://doi.org/10.33653/jkp.v9i2.901>
- Oktiningrum, M., Isti Harjanti, A., Nurhidayah, A., Dewi, I., & Ayu Fariska, L. (2023). Literatur Review: Pemanfaatan Bahan Alam GunaMemperlancar ASI pada Ibu Menyusui. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 2(1), 2023. <https://callforpaper.unw.ac.id/index.php/semnasdancfpbidanunw/article/view/442>

- Prentice, A. M. (2022). Breastfeeding in the Modern World. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 78(suppl 2), 29–38. <https://doi.org/10.1159/000524354>
- Ramadhani, P. A., Nuryanti, D., Syafira, A. N., Shafiyah, A. R., & Retnowati, Y. (2023). Makanan Sehat Untuk Memperlancar Produksi ASI. *Jurnal Kesehatan Republik Indonesia*, 1(1), 40–46.
- Unicef. (2024). *Ibu Membutuhkan Lebih Banyak Dukungan Menyusui Selama Masa Kritis Bayi Baru Lahir*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/ibu-membutuhkan-lebih-banyak-duktungan-menyusui-selama-masa-kritis-bayi-baru-lahir>
- Yuliani, N. R., Larasati, N., Setiwandari, & Nurvitriana, N. C. (2022). Peningkatan Produksi ASI Ibu Menyusui dengan Tatalaksana Kebidanan Komplementer. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, III(3), 17–27. <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/166>
- Yuliawati, Y., Novializa, I., & Sadiman, S. (2023). Kelancaran Pemberian Asi Dengan Simplisia Daun Katuk Dan Madu Ternak Murni Pada Ibu Menyusui. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1757–1761. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.887>
- Yuniartis, P. (2023). Penggunaan Galaktogog Alami Pada ibu Nifas. *Journal of Midwifery Science and Women's Health*, 3(2), 78–86. <https://doi.org/10.36082/jmswh.v3i2.1084>

Glosarium

A

Akupresur: adalah metode pengobatan tradisional Tiongkok dengan menekan titik-titik tertentu di tubuh seseorang tanpa menggunakan jarum

Akupunktur: adalah metode pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan penggunaan jarum-jarum kecil untuk menstimulasi titik-titik spesifik pada tubuh.

Alkaloid: adalah senyawa organik basa yang banyak ditemukan di tumbuhan dan mengandung nitrogen. Mereka juga ada di hewan, bakteri, dan fungi

Amaranthus spp: adalah nama ilmiah untuk kelompok tanaman bayam

B

Barley Malt: adalah hasil olahan dari biji gandum barley (jelai) yang telah mengalami proses perendaman, perkecambahan, dan pengeringan

C

Coleus Amboinicus: adalah nama ilmiah dari Daun jinten atau torbangun

F

Fenugreek: adalah tanaman kelabat yang bijinya sering digunakan sebagai bumbu masakan, suplemen kesehatan, dan ramuan tradisional

Fitokimia: adalah ilmu yang mengkaji senyawa organik yang berasal dari tumbuhan.

Fitosterol: adalah juga dikenal sebagai sterol tumbuhan, adalah senyawa lemak nabati yang memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Flavonoid: adalah senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan yang dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, teh, dan cokelat.

G

Galactagogue: adalah zat atau makanan yang merangsang dan meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui.

K

Kolostrum: adalah cairan ASI pertama yang keluar dari payudara ibu setelah melahirkan, yang berwarna kuning keemasan dan lebih kental daripada ASI.

L

Laktagogum: adalah zat yang dapat meningkatkan produksi ASI

Laktogenik: adalah makanan atau minuman yang mengandung zat-zat yang dapat merangsang dan meningkatkan produksi ASI

M

Moringa Oleifera: adalah nama ilmiah dari Daun kelor

O

Oksitosin: adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yang berperan dalam merangsang kontraksi rahim, mendukung produksi ASI, dan memperkuat ikatan emosional antara individu, serta dapat mengurangi stress dan cemas.

P

Polifenol: adalah senyawa alami yang memiliki sifat antioksidan dan ditemukan dalam banyak makanan dan minuman, seperti kacang-kacangan, cokelat, teh, kopi, buah, dan sayuran.

Prolaktin: adalah Prolaktin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari yang berperan penting dalam merangsang dan mempertahankan produksi ASI setelah melahirkan.

S

Saponin: adalah metabolit sekunder tanaman yang ditemukan di berbagai bagian tanaman, seperti daun, buah, biji, umbi, batang, dan akar.

Sauropus Androgynus: adalah nama ilmiah dari daun katuk

Sesbania Grandiflora: adalah nama ilmiah dari daun turi

Steroid: adalah bahan alami dalam tubuh manusia dan hewan dan bertanggung jawab atas berbagai proses fisiologis, termasuk pengaturan hormon, peradangan, dan sistem kekebalan tubuh.

T

Trigonella foenum-graceum: adalah nama ilmiah dari Biji klabet

W

Wang Nam Yen: adalah ramuan tradisional Thailand yang dikenal dapat menyegarkan tubuh dan meredakan berbagai keluhan kesehatan.

BAB III

PENGARUH NUTRISI TERHADAP KUALITAS ASI

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu menyusui sangat penting karena berpengaruh langsung pada Air Susu Ibu (ASI) sebagai satu satunya makanan terbaik bagi bayi. Periode 1.000 hari pertama kehidupan anak merupakan masa penting yang menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Pada masa ini, sangat penting untuk memberikan nutrisi yang cukup melalui pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan ASI (MP-ASI), serta pemantauan tumbuh kembang yang cermat.

Menyusui adalah salah satu investasi yang terbaik, termasuk untuk meningkatkan kesehatan, perkembangan social, serta ekonomi individu dan bangsa. ASI eksklusif dan menyusui 24 bulan penting bagi bayi terutama mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ibu menyusui merupakan salah satu sasaran Gerakan 1000 HPK selain Ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak usia di bawah dua tahun. Gerakan 1000 HPK merupakan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sayangnya, gerakan ini tidak menunjukkan perhatiannya pada gizi ibu menyusui. Hal ini terlihat dari jenis intervensi gizi spesifik dan sensitif selama masa 1000 HPK, hanya terfokus pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan bayi berusia enam bulan hingga dua tahun, sedangkan ibu menyusui tidak mendapatkan perhatian intervensi tentang gizinya.

B. Kualitas ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan alami terbaik bagi bayi, dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Namun fenomena yang terdapat di masyarakat saat ini pemberian ASI eksklusif masih rendah (Ichsan *et al.*, 2020). Menurut *World Health Organization* (WHO) 2022 menyebutkan bahwa hingga 2 dari 3 bayi di dunia tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Data dari *International Baby Food Action Network* (IBFAN) mencatat Indonesia menempati peringkat ketiga dari 51 negara terbawah di dunia dalam pemberian ASI eksklusif (Novitasari, Raharjo dan Wijayanti, 2019). Hasil informasi Riskesdas tahun 2013 cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia sebesar 38,0% bahkan laporan Riskesdas tahun 2018 menyebutkan mengalami penurunan menjadi 37,3%.

ASI adalah makanan terbaik yang dapat diberikan ibu pada bayinya baik yang cukup bulan maupun yang kurang bulan. ASI lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang sedang berkembang, dibandingkan dengan susu formula atau makanan tambahan lainnya. Selain memberikan manfaat besar bagi bayi, menyusui juga memberikan banyak keuntungan bagi ibu. Proses menyusui dapat mempercepat pemulihan setelah melahirkan, mengurangi risiko perdarahan pasca-persalinan, serta menurunkan kemungkinan terkena kanker payudara dan ovarium di masa depan (Abid *et al.*, 2021).

ASI yang dikonsumsi bayi tidak cukup hanya secara kuantitas tapi kualitas ASI. Kuantitas dan Kualitas ASI ditentukan oleh zat gizi ibu menyusui, diantaranya kebiasaan dan frekwensi makanan. Pendapatan yang cukup suatu keluarga bukan merupakan suatu jaminan bahwa kebutuhan gizi tercukupi dengan baik (Marissa *et al.*, 2023).

Tabel 1. Komposisi ASI bayi cukup bulan (ACB) dan ASI bayi kurang bulan (AKB) selama bulan pertama Menyusui

Zat gizi	3-5 hari		8-11 hari		15-18 hari		26-29 hari	
	ACB	AKB	ACB	AKB	ACB	AKB	ACB	AKB
Energi (kkal/dL)	48	58	59	71	62	71	62	70
Lemak (g/dL)	1.85	3.00	2.9	4.14	3.06	4.33	3.05	4.09
Protein (g/dL)	1.87	2.10	1.7	1.86	1.52	1.71	1.29	1.41
Laktosa (g/dL)	5.14	5.04	5.98	5.55	6.00	5.63	6.51	5.9

Keterangan: ACB: Anak Cukup Bulan, AKB: Anak Kurang Bulan

Proses menyusui merupakan proses interaktif sehingga bayi dapat terlibat membantu menentukan komposisi ASI. Perubahan komposisi seperti ini tidak dapat diberikan kalau bayi mendapat susu formula. Komposisi ASI dipengaruhi oleh usia gestasi, usia paskanatal, stadium penyusuan (pada permulaan atau akhir menyusui), frekuensi bayi menyusu serta asupan harian ibu. Pada tabel 1 terlihat perubahan komposisi ASI dari ibu yang melahirkan anak cukup bulan (ACB) dibandingkan ASI dari ibu yang melahirkan anak kurang bulan (AKB) selama 1 bulan postnatal (Suradi, 2001).

Komposisi ASI khususnya energi sekitar 50% berasal dari lemak. Lemak ASI adalah komponen yang paling berubah kadarnya. Lemak ASI terutama terdiri atas trigliserida yang mudah diuraikan menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh enzim lipase yang terdapat dalam usus bayi dan dalam ASI (Suradi, 2001). Bayi yang mendapat ASI dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula mempunyai kadar asam asetat dari spektrum asam lemak berantai pendek yang lebih tinggi. Asam asetat ini bersama monogliserida berfungsi menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan fungus (Suradi, 2001). Perbedaan warna, konsistensi dan bau feses bayi yang mendapat ASI dan susu formula disebabkan oleh karena kadar sabun yang lebih tinggi pada feses bayi yang mendapatkan ASI (Suradi, 2001).

Karbohidrat juga merupakan sumber energi ASI, yang disebut laktosa. Laktosa merupakan karbohidrat disakarida hanya terdapat dalam air susu dan tidak terdapat dalam jaringan tubuh lain. Laktosa berada dalam konsentrasi yang paling tinggi di dalam ASI bila dibandingkan dengan air susu mamalia lain dan sering dihubungkan dengan berat otak yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan otak mamalia lain. Laktosa berperan dalam meningkatkan absorpsi Kalsium dan mudah terurai menjadi glukosa yang menjadi sumber energi untuk pertumbuhan otak dan galaktosa yang diperlukan untuk produksi galaktolipids (antara lain cerebroside) yang esensial untuk perkembangan otak. Selain itu dalam ASI terdapat juga oligosakarida yang merangsang pertumbuhan *Laktobasilus bifidus* yang meningkatkan keasaman traktus digestivus dan menghambat pertumbuhan kuman patogen. Hal inilah menyebabkan bayi yang diberikan ASI secara eksklusif akan jarang sakit dibanding dengan bayi yang mendapatkan susu formula sebelum berusia 6 bulan.

C. Asupan ibu Menyusui

AKG (2019) ibu menyusui 6 bulan pertama membutuhkan tambahan energi dan asupan zat gizi makro yaitu energi 330 kkal/hari, karbohidrat 45 gram/hari, lemak 2,2 gram/hari dan protein 20 gram/hari. Sedangkan pada ibu menyusui 6 bulan kedua memerlukan penambahan energi dan asupan zat gizi makro, energi sebesar 400 kkal/hari, karbohidrat sebesar 55 gram/hari, lemak sebesar 2,2 gram/hari dan protein sebesar 15 gram/hari (PMK No 28, 2019). Asupan gizi ibu menyusui sangat berpengaruh dalam membantu proses pembentukan ASI (Arum dan Widiyawati, 2017).

Asupan gizi yang seimbang pada ibu menyusui akan memastikan kandungan zat gizi dalam ASI, seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral, tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bayi. Sebuah studi mencatat asupan energi sebesar 1728,6 Kkal (67%) dari AKG, masing-masing asupan zat gizi makro protein, lemak,

karbohidrat sebesar 52,8 g (66%) AKG, 59,63 g (60%) AKG, 186,3 g (46%) AKG, dan zat besi 1008 mg (56%) AKG (Wijayanti dan Zulkarnain, 2021). Kurangnya asupan zat gizi makro, zat besi dan kalsium ibu menyusui berkontribusi terhadap penurunan produksi ASI (Maharani, Pangestuti dan Pradigdo, 2016). Kekurangan gizi ibu menyusui akan menimbulkan masalah pada kelenjar pituitari untuk memproduksi ASI tidak dapat bekerja dengan baik (Maryatun, Wardhani dan Prajayanti, 2019).

Asupan gizi ibu selama menyusui memengaruhi energi, komponen makronutrien dan mikronutrien dalam ASI. Pemenuhan gizi seimbang sangat dianjurkan untuk ibu menyusui terutama bahan makanan bersumber protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, zat besi dan seng, yang nantinya digunakan untuk memproduksi ASI, metabolisme tubuh ibu dan berpengaruh terhadap komposisi ASI yang diberikan kepada bayinya (Sultana *et al.*, 2022). Asupan zat gizi ibu menyusui yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kualitas produksi ASI. Semakin baik makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui, maka semakin tinggi ketercapaian asupan zat gizi ibu, dan sebaliknya jika asupan zat gizi pada ibu menyusui rendah, maka akan berpengaruh pada kecukupan asupan zat gizi dan menyebabkan rendahnya kualitas produksi ASI (Maryatun, Wardhani dan Prajayanti, 2019). Oleh karena itu ibu menyusui memerlukan tambahan zat gizi yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI, terutama asupan zat gizi makro (Salamah dan Prasetya, 2019).

Ibu menyusui tidak perlu terlalu ketat dalam mengatur pola makannya, yang paling penting adalah memilih makanan yang dapat mendukung pembentukan ASI berkualitas dan mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan bayi. Saat menyusun menu harian, ibu perlu memperhatikan keseimbangan porsi dan variasi makanan dengan mengikuti pedoman ISI PIRINGKU. Makanan yang dipilih sebaiknya mudah dicerna, tidak terlalu merangsang pencernaan, dan tidak menyebabkan sembelit (kecuali jika ibu memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu) (Taneja *et al.*, 2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, ibu menyusui setidaknya memerlukan 330 kalori tambahan per harinya, atau total sekitar 2600 kalori. Energi tambahan ini digunakan untuk mendukung produksi ASI yang memadai. Produksi ASI membutuhkan energi yang cukup agar tubuh dapat menghasilkan susu yang cukup untuk bayi. Ibu menyusui perlu memastikan bahwa energi tambahan ini berasal dari sumber makanan bergizi (Huang dan Hu, 2020).

Ibu menyusui membutuhkan protein sebanyak 71 gram per hari. Protein sangat penting dalam proses pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh serta

mendukung produksi ASI. Protein juga berperan dalam memperbaiki jaringan tubuh ibu yang mungkin mengalami kerusakan selama proses persalinan dan pemulihan pasca melahirkan. Sumber protein yang baik meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, dan sumber nabati seperti kacang-kacangan serta biji-bijian.

Ibu menyusui membutuhkan cara memperlancar ASI, dengan memanfaatkan bahan makanan alami yang bisa dikonsumsi untuk memperlancar ASI, diantaranya susu kedelai, snack bar kacang merah, daun katuk, daun pepaya, jamu. Kacang-kacangan dapat menstabilkan produksi ASI. Ibu dengan rutin mengonsumsi kacang-kacangan sejak hamil hingga melahirkan menghasilkan ASI dua kali lebih banyak dan lebih kental saat menyusui dibandingkan dengan ibu yang tidak rutin mengonsumsi kacang-kacangan (Permatasari dan Indrawati 2022).

Selain memperhatikan konsumsi kacang-kacangan, ibu menyusui juga perlu memastikan asupan asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA, tercukupi. Kekurangan asam lemak ini dapat memengaruhi produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak ibu mengonsumsi asam lemak jenuh (SFA) dalam jumlah tinggi, sementara asupan asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dan tak jenuh ganda (PUFA) cenderung rendah. Selain itu, banyak ibu menyusui yang mengalami defisiensi asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA. Asam lemak omega-3 ini sangat penting bagi perkembangan otak dan fungsi visual bayi. Ketersediaan asam lemak jangka panjang, seperti AA dan DHA, bagi bayi sangat bergantung pada transfer nutrisi tersebut dari ibu, baik melalui plasenta selama kehamilan maupun melalui ASI saat menyusui. Oleh karena itu, pola makan ibu dan metabolisme asam lemaknya akan memengaruhi kadar asam lemak jangka panjang dalam ASI. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asupan DHA ibu sangat memengaruhi konsentrasi DHA dalam ASI (Rachmadiani dan Nadhiroh, 2024) (Carretero-krug *et al.*, 2024) .

Semakin tinggi dosis DHA yang dikonsumsi oleh ibu, semakin besar pula peningkatan kadar DHA dalam ASI, meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada pola makan dan status gizi ibu. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa cukupnya asupan DHA selama masa menyusui sangat penting untuk mendukung perkembangan sistem saraf bayi serta meningkatkan kemampuan penglihatan dan belajar di masa depan. Peningkatan asupan DHA dapat dicapai dengan mengonsumsi sumber makanan kaya omega-3, seperti ikan laut, minyak ikan, atau suplemen berbasis minyak ikan. Selain itu, konsumsi ALA dari sumber nabati, seperti biji rami, kacang walnut, atau minyak kedelai, juga dapat membantu meningkatkan kadar DHA dalam ASI (Carretero-krug *et al.*, 2024). Ibu menyusui disarankan mengonsumsi ikan berlemak, alpukat, dan kacang-kacangan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kecukupan zat gizi ibu menyusui yaitu dengan pemberian makanan tambahan (Okinarum, Lestariningsih dan Dewi, 2020). Selama ini program pemberian makanan tambahan yang dilakukan pemerintah pada ibu menyusui berupa suplementasi kapsul vitamin A, biskuit dan susu belum menyentuh sasaran ibu menyusui secara keseluruhan hanya ibu dengan KEK saja.

Seringkali perhatian lebih terfokus pada kebutuhan bayi selama masa menyusui, sementara pola makan ibu menyusui sering kali terabaikan. Padahal, asupan zat gizi yang cukup bagi ibu sangat penting untuk menjaga kesehatannya dan memastikan kualitas ASI yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, ibu disarankan untuk mengonsumsi suplemen, terutama bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dari makanan sehari-hari. Kebutuhan akan suplemen selama menyusui tergantung pada berbagai faktor, seperti kebiasaan makan ibu. Namun, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara suplementasi gizi pada ibu menyusui dengan peningkatan konsentrasi beberapa nutrisi penting dalam ASI, seperti asam lemak omega-3 (DHA dan EPA), vitamin D, dan yodium, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Penelitian juga mengindikasikan bahwa peningkatan asupan zat gizi tertentu melalui suplementasi dapat langsung mempengaruhi kadar zat gizi dalam ASI, meskipun efeknya dapat bervariasi tergantung pada jenis zat gizi, dosis yang diberikan, serta status gizi ibu. Oleh karena itu, rekomendasi suplementasi untuk ibu menyusui harus disesuaikan dengan kebutuhan individu untuk memastikan bayi memperoleh zat gizi yang optimal melalui ASI (Carretero-krug *et al.*, 2024).

Defisiensi vitamin A, B12, asam folat, dan vitamin D, serta kekurangan mineral kalsium, besi, dan yodium, sering ditemukan pada ibu menyusui. Upaya untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan melalui diversifikasi pola makan yang mengandung sumber nutrisi tersebut, seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan berwarna, produk susu, telur, daging, ikan, dan produk kacang-kacangan.

D. Peran Asupan Ibu dalam Meningkatkan Kualitas ASI

Di awal menyusui, meskipun asupan energi dan protein ibu dari hidangan sehari-hari masih kurang, kandungan zat gizi ASI masih baik hal ini dikarenakan ibu menyusui masih menyimpan cadangan lemak selama hamil. Namun jika kondisi tersebut terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, cadangan lemak selama hamil akan semakin menipis dan jika tidak diimbangi dengan asupan zat gizi yang cukup ibu berisiko mengalami kekurangan zat gizi (Maharani, Pangestuti dan Pradigdo, 2016) (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2018). Selain itu ibu menyusui

juga masih harus memproduksi ASI untuk menyusui bayinya. Apabila ibu kekurangan zat gizi untuk memproduksi ASI, maka zat gizi akan diambil dari tubuh ibu terus menerus, sehingga ibu harus menggantinya dengan suplai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ibu yang tidak mampu menggantikan zat gizi yang diberikan kepada bayi melalui asupan makanan akan mengalami gizi kurang atau bahkan gangguan kesehatan (Wardhani dan P, 2019).

Sebuah studi yang dilakukan pada 66 ibu menyusui sebelum diberi intervensi berupa kukis ikan gaguk 80 g setiap hari selama 14 hari diperoleh pemenuhan kebutuhan energi ibu menyusui hanya berkisar (70-74%), protein (67-69%), lemak (69-70%), karbohidrat (61-62%), kalsium (59-62%), zat besi (35-38%) AKG. Dengan pemberian kukis meningkatkan asupan ibu dan keadaan ini tentunya berdampak terhadap kualitas ASI.

Kualitas ASI yang baik tergantung pada kandungan zat gizi makro dan mikro yang cukup. Zat gizi makro yang terkandung dalam ASI yang optimal meliputi lemak sekitar 3,5-4,5 g per 100 ml, karbohidrat (terutama laktosa sebanyak 7 g per 100 ml, dengan glukosa 1,4 g per 100 mL dan galaktosa 1 g per 100 mL), serta protein sebanyak 0,9-1,5 g per 100 mL. Selain itu, ASI juga mengandung zat gizi mikro seperti mineral (kalsium 280 mg/L, fosfor 140 mg/L, dan zat besi 0,35 mg/L), serta vitamin (vitamin A 75 µg/100ml, vitamin E 0,25 mg/mL, dan vitamin C 5 mg/100 mL). Kandungan ASI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola makan ibu, status gizi ibu, dan tahap laktasi ibu (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2021) (Simanjutak *et al.*, 2024).

Produksi dan sekresi ASI merupakan proses fisiologis kompleks yang melibatkan kelenjar susu dan hubungan yang erat antara sistem hormonal dan faktor maternal. Seluruh aspek tersebut berkontribusi dalam fungsi sekretori yang terkoordinasi oleh sel epitel payudara yang kemudian akan menghasilkan ASI dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan bayi. Protein dalam ASI dibentuk mulai dari ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2021).

Kandungan protein dalam ASI bersifat dinamis selama menyusui hal ini terkait erat dengan asupan ibu menyusui dan lingkungan. Selama menyusui, ibu membutuhkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan payudara, volume ASI dan Kualitas ASI. Ibu menyusui membutuhkan asupan protein 75- 80 gr/hari atau bertambah 15-20gr perhari dari ibu yang tidak menyusui. Pada masa menyusui tubuh membutuhkan asupan protein lebih banyak 20 gr/ hari dari kebutuhan biasa sebesar 60 gr/hari (RI, 2019). Selama menyusui ibu harus dapat memenuhi kebutuhan asupan makanan baik asupan protein maupun asupan gizi lainnya. Karena selama masa menyusui asupan zat gizi harus ditingkatkan untuk memenuhi

kebutuhan energi dalam proses menyusui dan juga untuk recovery pasca persalinan serta untuk meningkatkan proses pembentukan ASI yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI (Marissa *et al.*, 2023).

Penelitian mengenai hubungan antara asupan protein ibu menyusui dan kandungan protein dalam ASI menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. Protein yang dikonsumsi ibu melalui makanan akan dicerna dalam sistem pencernaan dan diserap ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya, protein tersebut dibawa oleh darah ke berbagai jaringan tubuh, termasuk ke kelenjar payudara, tempat di mana ASI diproduksi (Yves *et al.*, 2021). Oleh karena itu, peningkatan asupan protein ibu secara langsung berpengaruh pada peningkatan kadar protein yang terkandung dalam ASI, yang pada gilirannya mendukung kualitas ASI yang optimal.

Pembentukan protein dalam ASI dimulai dengan konsumsi sumber makanan yang mengandung protein oleh ibu. Setelah makanan mencapai lambung, protein akan dicerna oleh enzim pepsin yang bekerja bersama asam klorida (HCl), mengubahnya menjadi metabolit intermediate berupa polipeptida, seperti peptone, albumosa, dan proteosa. Selanjutnya, di duodenum, protein yang telah diproses tersebut akan dicerna lebih lanjut oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus halus. Enzim proteolitik seperti tripsin dan kimotripsin yang dihasilkan pankreas, serta enzim erepsin yang disekresikan oleh usus halus, bekerja untuk memecah protein lebih lanjut. Proses pencernaan ini menghasilkan asam amino yang diserap oleh sel-sel epitelium di dinding usus halus. Setelah diserap, asam amino tersebut dibawa oleh darah ke berbagai jaringan tubuh, di mana mereka digunakan dalam berbagai proses anabolik dan katabolik, termasuk sintesis hormon yang berperan penting dalam produksi ASI.

Zat gizi makro yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi ibu akan diolah menjadi cairan ASI setelah dicerna dalam tubuh. Proses pencernaan ini menghasilkan zat gizi yang kemudian dibawa oleh sel darah ke seluruh tubuh, dan salah satu tempat distribusinya adalah kantung ASI. Selama periode menyusui, asupan zat gizi makro harus ditingkatkan, karena ibu membutuhkan energi tambahan untuk pemulihan pasca persalinan serta untuk mendukung proses metabolisme yang terlibat dalam produksi ASI (Simanjutak *et al.*, 2024). Pada bulan pertama pasca persalinan, produksi ASI biasanya sangat melimpah untuk memenuhi kebutuhan bayi, sehingga ibu cenderung merasa lebih cepat haus dan lapar. Untuk memastikan bahwa energi yang dikeluarkan sebanding dengan energi yang dikonsumsi, ibu memerlukan asupan makanan dengan gizi seimbang untuk mendukung produksi ASI (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2018). Pada wanita

dengan status gizi yang baik, rata-rata volume ASI yang diproduksi berkisar antara 700 hingga 800 mL per hari.

Ibu menyusui perlu memastikan asupan makanannya bergizi dan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk mendukung metabolisme tubuh, fungsi organ tubuh, serta pembentukan ASI (Mahayati, 2017). Oleh karena itu, penting bagi ibu menyusui untuk meningkatkan asupan makanannya, terutama yang mengandung protein, karena protein sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kekurangan protein pada bayi dapat menyebabkan masalah gizi, seperti stunting, akibat defisit protein (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2021).

Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk kebutuhan pemenuhan energi, protein, dan gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan produksi ASI. Kualitas ASI dan komposisi nutrisi pada setiap ibu menyusui akan berbeda-beda. Mikronutrien adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang sedikit namun diperlukan. Air susu ibu (ASI) terdiri dari hampir 90% nya dari air. di dalam ASI maupun susu formula keduanya rendah serta bervariasi. Hal ini disebabkan karena zat besi yang berasal dari ASI dapat mudah untuk diserap, yaitu 20-50% dibandingkan hanya 4-7% pada susu formula sedangkan kebutuhan zat besi yang diperlukan pada ibu menyusui sekitar 20 mg keatas (Sari dan Azis, 2023).

Asam lemak omega-3 adalah jenis asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Omega-3 memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan balita. Setelah anak berusia lebih dari 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI menjadi penting karena kandungan omega-3 dalam ASI mulai menurun pada usia tersebut, yang sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Pada anak yang berusia lebih dari 6 bulan, kadar omega-3 dalam ASI mengalami penurunan, sementara omega-9 justru meningkat. Omega-9 adalah asam lemak yang dapat menggantikan omega-3 atau omega-6 jika kedua asam lemak tersebut tidak mencukupi dalam tubuh.

Studi tentang pengaruh pemberian ASI hingga usia 24 bulan, terlihat bahwa kandungan omega-3 lebih rendah dibandingkan omega-9. Untuk memenuhi kebutuhan omega-3, bayi perlu memperoleh asupan dari luar karena tubuh tidak dapat memproduksi omega-3 yang merupakan asam lemak esensial. Berbeda dengan zat besi, bayi dapat memenuhi kebutuhan zat besinya hanya melalui ASI jika diberikan minimal selama 3 bulan. ASI juga memberikan kontribusi besar dalam mencukupi kebutuhan sang bayi, bahkan setelah pemberian makanan pendamping mulai diperkenalkan dan hingga memasuki tahun kedua kehidupan. Untuk

pemenuhan zat besi dan zink ini, diharapkan konsumsi zat besi ibu harus terjamin hingga anak berusia 24 bulan.

Kandungan protein dalam ASI sangat dipengaruhi oleh asupan protein yang diterima oleh ibu menyusui. Protein yang dikonsumsi ibu akan dipecah menjadi asam amino, terutama asam amino esensial yang hanya dapat diperoleh dari makanan karena tubuh tidak dapat memproduksinya. Asam amino ini berperan penting dalam sintesis protein ASI di kelenjar susu. Kekurangan asam amino yang diperlukan untuk ASI dapat mengganggu metabolisme dan mempengaruhi pertumbuhan bayi (Wardana, Widyastuti dan Pramono, 2021). Sebaiknya, sekitar seperlimanya dari total asupan protein yang dikonsumsi ibu berasal dari sumber protein hewani, seperti daging, ikan, telur, susu, dan yogurt, sementara sisanya berasal dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Ibu yang rutin mengonsumsi tempe dan tahu akan meningkatkan kadar asam amino esensial, terutama fenilalanin.

Penelitian yang dilakukan di propinsi Bengkulu mengemukakan bahwa semakin dewasa usia ibu menyusui, rata-rata kandungan protein ASI pada ibu semakin rendah. Ibu berusia 17-29 tahun memiliki protein ASI sebesar 0,63 g/100mL dan rentang usia 30-49 tahun adalah 0,43g/100mL (Simanjutak *et al.*, 2024). Hasil penelitian serupa didapatkan bahwa rata-rata kandungan protein ASI pada ibu yang berusia < 32 tahun yakni 1,96 g/dL dan usia ibu $\geq$ 32 tahun 1,83 g/dL (Koutsiafti, Soultani dan Malissiova, 2021). Ibu menyusui di usia lebih muda dan sedang mengalami proses pertumbuhan fisik akan mempengaruhi kandungan protein ASI. Selain itu, variasi komposisi protein juga dipengaruhi oleh paritas, status kesehatan mental, kondisi fisik ibu (Verd *et al.*, 2018).

Mengenai karbohidrat yang dikonsumsi ibu akan mengubah komponen-komponen dalam ASI, seperti oligosakarida, berperan dalam mendukung pertumbuhan beberapa jenis mikroba. Selain itu, zat-zat seperti lisozim, laktoferin, dan peptida antimikroba dapat menghambat perkembangan bakteri patogen penyebab penyakit. Penularan bakteri melalui ASI berpotensi untuk memodulasi kolonisasi dan perkembangan saluran pencernaan bayi baru lahir yang masih belum matang. Berbeda dengan susu formula bayi yang memiliki komposisi yang distandarisasi dengan rentang yang sangat terbatas, komposisi ASI bersifat dinamis dan bervariasi setiap kali pemberian makan. Mikrobiota yang ada di sekitar areola dapat ditransmisikan ke bayi melalui ASI (Syahniar dan Suri, 2020).

Vitamin A memiliki peran penting dalam merangsang sekresi hormon prolaktin di otak dan mengaktifkan sel-sel epitel pada alveoli untuk memproduksi ASI (Qiao *et al.*, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Chahyanto dan Roosita (2013) juga

menunjukkan bahwa asupan vitamin A memiliki hubungan yang signifikan dengan produksi ASI. Semakin tinggi asupan vitamin A pada ibu menyusui, semakin baik pula kecukupan produksi ASI untuk bayi. Kandungan vitamin B6 di ASI terbukti mempercepat perkembangan bayi, terlihat dari peningkatan signifikan panjang bayi, lingkar kepala dan berat badan (Ruslie, 2012).

E. Penutup

Upaya peningkatan nutrisi ibu menyusui merupakan hal yang krusial untuk mendukung produksi dan kualitas ASI yang optimal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Pemenuhan asupan gizi yang seimbang akan memastikan kandungan kualitas ASI. Semakin tinggi asupan energi dan protein ibu menyusui mengindikasikan semakin tinggi kandungan protein ASI.

Referensi

- Abid, N. *et al.* (2021) "Breastfeeding Knowledge , Attitude and Practices of New-Mothers Presenting in Obstetrical Out-Patient Department," *Annals of Punjab Medical College*, 15(1), hal. 40–50. doi: 10.29054/APMC/2021.956.
- Arum, P. dan Widiyawati, A. (2017) "Kandungan Gizi Asi (Air Susu Ibu) Pada Berbagai Suhu Dan Lama Penyimpanan," *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16(3), hal. 48–51. doi: 10.25047/jii.v16i3.311.
- Carretero-krug, A. *et al.* (2024) "Nutritional Status of Breastfeeding Mothers and Impact of Diet and Dietary Supplementation : A Narrative Review," hal. 1–28.
- Huang, Z. dan Hu, Y. (2020) "Dietary Patterns And Their Association With Breast Milk macronutrient Composition Among Lactating Women," hal. 1–10.
- Ichsan, B. *et al.* (2020) "Barriers And Support To Exclusive Breastfeeding in Sukoharjo District, Central Java Province, Indonesia: a Qualitative Study," *Journal of Health Research*, 35(6), hal. 482–492. doi: 10.1108/JHR-12-2019-0274.
- Koutsiafti, P., Soultani, G. dan Malissiova, E. (2021) "Macronutrient Composition of Breast Milk for Full Term and Premature Infants : Correlation to Nutritional and Socioeconomic Factors," 14(1), hal. 608–616.
- Maharani, H., Pangestuti, D. R. dan Pradigdo, S. F. (2016) "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang," 4(April), hal. 187–196.
- Mahayati, L. (2017) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Dalam Pemenuhan Nutrisi Pada Masa Nifas Di Bps Mien Hendro Sidoarjo," (20).
- Marissa, F. *et al.* (2023) "Studi Cross Sectional Terhadap Hubungan Asupan Protein Dengan Kadar Protein Total Asi Pada Ibu Menyusui," 15.
- Maryatun, M., Wardhani, D. K. dan Prajayanti, E. D. (2019) "Peningkatan Produksi ASI Ibu Menyusui Pasca Melalui Pemberian Pijat Oksitosin dan Terapi Musik Klasik (Mozart) Wilayah Kerja Puskesmas Kradenan 2," *Gaster*, 17(2), hal. 188. doi: 10.30787/gaster.v17i2.400.
- Novitasari, T., Raharjo, B. B. dan Wijayanti, Y. (2019) "The Analysis of Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in Grobogan Regency," *Public Health Perspective Journal*, 4(3), hal. 240–248.
- Okinarum, G. Y., Lestariningsih, L. dan Dewi, D. P. (2020) "Potency of cookies substituted with fenugreek (*Trigonella foenum – graecum*) and banana blossom (*Musa balbisiana* L . A . Colla) flour to increase breastmilk volume," 3(2), hal. 135–144. Tersedia pada: doi: <https://doi.org/10.35842/ilgi.v3i2.138>.
- PMK (2019) *No PMK No 28, 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Qiao, Y. *et al.* (2013) "The Relationship between Dietary Vitamin A Intake and the Levels

- of Sialic Acid in the Breast Milk of Lactating Women," hal. 347–351.
- Rachmadiani, A. P. dan Nadhiroh, S. R. (2024) "The Nutritional Status of Breastfeeding Mothers and Breastfeeding Adequacy in Indonesia : A Systematic Review," 09, hal. 450–461.
- Ruslie, R. H. (2012) "Peranan Vitamin sebagai Nutrisi pada Bayi," *UNISSULA*, 4(1), hal. 97–111.
- Salamah, U. dan Prasetya, P. H. (2019) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Ibu Dalam Pemberian Asi Eksklusif," *Jurnal Kebidanan*, 5(3), hal. 199–204. doi: 10.33024/jkm.v5i3.1418.
- Sari, R. N. dan Azis, L. (2023) "Science and Technology Penilaian Status Gizi Ibu Menyusui Eksklusif Dengan Metode 24 H Recall Di Kecamatan Sumbawa," 7(2), hal. 8–17.
- Simanjutak, B. Y. *et al.* (2024) "Food intake of breastfeeding mothers versus protein content of breastmilk in the coastal area of Bengkulu, Indonesia," (*Afr J Reprod Health*, 28(5), hal. 22–29. doi: 10.29063/ajrh2024/v28i5.3.
- Sultana, M. *et al.* (2022) "Knowledge , Attitudes , And Predictors Of Exclusive Breastfeeding Practice Among Lactating Mothers In Noakhali , Bangladesh," 8(October 2021). doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11069.
- Suradi, R. (2001) "Spesifitas Biologis Air Susu Ibu," *Sari Pediatri*, 3(3), hal. 134–140.
- Syahniar, R. dan Suri, A. A. (2020) "Profil Mikrobiota ASI dan Perannya terhadap Saluran Cerna Bayi," 1(1), hal. 8–16.
- Taneja, S. *et al.* (2021) "Impact Of Nutritional Interventions Among Lactating Mothers On The Growth Of Their Infants In The First 6 Months Of Life : A Randomized Controlled Trial In Impact Of Nutritional Interventions Among Lactating Mothers On The Growth Of Their Infants In The F," (February). doi: 10.1093/ajcn/nqaa383.
- Verd, S. *et al.* (2018) "Variation In The Protein Composition Of Human Milk During Extended Lactation: A Narrative Review," *Nutrients*, 10(8), hal. 1–10. doi: 10.3390/nu10081124.
- Wardana, R. K., Widyastuti, N. dan Pramono, A. (2018) "Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Status Gizi Ibu Menyusui dengan Kandungan Zat Gizi Makro pada Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Bandarharjo Semarang," *Journal of Nutrition College*, 7(3), hal. 107. doi: 10.14710/jnc.v7i3.22269.
- Wardana, R. K., Widyastuti, N. dan Pramono, A. (2021) "Hubungan Asupan Zat Gizi Makro Dan Status Gizi Ibu Menyusui Dengan Kandungan Zat Gizi Makro Pada Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Badarharjo Semarang," *Journal of Nutrition College*, 7(3), hal. 372–378. doi: 10.14710/jnc.v7i3.22269.
- Wardhani, D. K. dan P, E. D. (2019) "Peningkatan Produksi Asi Ibu Menyusui Pasca Melalui Pemberian Pijat Oksitosin dan Terapi Musik Klasik (Mozart) Wilayah

Kerja Puskesmas Kradenan 2," 17(2).

- Wijayanti, E. dan Zulkarnain, Z. (2021) "Pengaruh Asupan Zat Gizi Dan Jamu Pelancar Air Susu Ibu (ASI) Terhadap Kadar Zat Besi (Fe) ASI Ibu Menyusui," *Media Gizi Masyarakat Indonesia*, 12(2), hal. 107–118. Tersedia pada: doi: <https://doi.org/10.22435/mgmi.v12i2.3926>.
- Yves, C. *et al.* (2021) "Breast Milk Protein Content At Week 3 After Birth And Neurodevelopmental Outcome In Preterm Infants Fed Fortified Breast Milk," *European Journal of Nutrition*, 60, hal. 3959–3969.

BAB IV

EDUKASI IBU MENYUSUI TENTANG POLA MAKAN SEHAT

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki target capaian cakupan ASI Eksklusif sebesar 39%, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan bahwa cakupan ASI Eksklusif pada bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan adalah 35,73%. Pemerintah berusaha mendukung, melindungi, dan mendorong pemberian ASI eksklusif (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data dari *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN),(Kementerian Kesehatan 2023). Kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945, hal ini disebabkan oleh bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat badan di bawah 2.500 gram. Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi di Indonesia antara lain faktor kesehatan anak, faktor lingkungan dan faktor nutrisi, faktor nutrisi ini dapat diatasi salah satunya dengan pemberian ASI. Untuk itu pemerintah berupaya menekankan angka kematian bayi dan balita dengan perbaikan gizi masyarakat melalui program pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif (Menkokestra, Kemenkes, 2011). ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi 0-6 bulan tanpa pemberian tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, biskuit, dan nasi tim (Haryono dan Setianingsih, 2014).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang pemberian ASI eksklusif di Indonesia diberikan selama enam bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai usianya, hal ini menjadi tugas utama tenaga kesehatan dalam memberikan layanan dengan cara menginformasikan pada ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI secara eksklusif. (Kemenkes RI, 2019). Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif, tenaga kesehatan berperanan memberikan edukasi terkait nutrisi / gizi seimbang pada ibu menyusui.



B. Edukasi Nutrisi Ibu Menyusui .

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa edukasi merupakan pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan mendorong praktik menyusui yang baik. Menurut penelitian (Naintina Lisnawati, Wilis Putu Purantira, 2023) edukasi perlu dilakukan secara dua arah atau perlu adanya interaksi indera penglihatan dan indera pendengaran, contoh edukasi yang efektif dengan melibatkan kedua indera tersebut salah satunya dengan media booklet, edukasi adalah pemberian informasi oleh pemateri kepada audien melalui media buku/ booklet dengan tujuan agar audien lebih mudah menyerap informasi, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan kesehatan adalah dengan memberi tahu orang-orang tentang kesehatan dan gizi saat usia bayi, terutama tentang pemberian ASI eksklusif dan manajemen laktasi sehingga hasil yang diharapkan dari memberi tahu ibu menyusui tentang ASI eksklusif adalah mereka akan lebih

memahami dan dapat menerapkan pemberian ASI yang baik dan benar pada bayi mereka. Pendidikan ASI meningkatkan inisiasi menyusui dini dan praktik pemberian ASI eksklusif, serta memberikan pendidikan berkelanjutan kepada perempuan tentang inisiasi dini dan praktik pemberian ASI eksklusif harus diperkuat (Diah Andriani Kusumastutia, 2022).

Pendidikan kesehatan terkait edukasi gizi dapat dilakukan dengan menggunakan media, sebagai upaya mendukung keberhasilan dalam promosi kesehatan, media pendidikan adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan akan membantu elemen lain dalam penyampaian pesan kesehatan sehingga informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat penerimaan audien, hal ini sama dengan penelitian Munir dkk, 2023 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian edukasi kesehatan tentang ASI eksklusif, perawatan payudara, dan teknik menyusui yang benar di Bangka Belitung terhadap peningkatan pengetahuan Ibu hamil untuk mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif yang diketahui dari hasil pre test dan post test (Munir et al., 2023).

Salah satu faktor besar yang mempengaruhi pemberian ASI adalah pengaruh lingkungan. Budaya yang didapat juga mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui atau tidak. Pengetahuan, peran pasangan, orang tua, tenaga kesehatan, sikap menyetujui kehamilan atau tidak, sangat mempengaruhi keputusan untuk menyusui atau tidak (Manuaba, 2012).

Tingkat pemahaman ibu terkait pentingnya ASI eksklusif bagi bayinya berpengaruh terhadap perilaku ibu untuk tidak menyusui bayinya. Pemahaman kurang dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang kurang, rendahnya pengetahuan, sikap dan informasi yang diterima. Berbagai faktor baik predisposisi, faktor pendukung dan pendorong sangat diperlukan bagi ibu, Upaya meningkatkan perilaku untuk mencapai kesehatan yang optimal perlu diberikan pendidikan kesehatan sebagai usaha atau kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan ibu (Notoatmojo, 2010). (Prananingrum, 2021) dalam penelitiannya terdapat pengaruh positif pemberian konseling dengan metode ceramah disertai diskusi terhadap praktik menyusui yang benar pada 30 respon ibu nifas



Sumber : googleimage

C. Gizi Ibu Menyusui terkait Pola Makan Sehat

Menyusui adalah salah satu investasi terbaik bangsa karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kebutuhan gizi ibu meningkat pada saat hamil dan menyusui karena di butuhkan oleh bayi, oleh karena itu asupan makan yang dikonsumsi ibu harus mencakup pola makan gizi yang cukup dan seimbang mencakup karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai sumber pembangun, vitamin dan mineral sebagai sumber pengatur dan pelindung (Anik, 2015).

Ibu hamil yang melahirkan bayinya, organ payudara bekerja untuk menghasilkan ASI, sehingga sangat wajar jika ibu merasa lapar setelah memberikan ASI, untuk itu ibu memerlukan makanan bergizi dengan menu pola makan sehat. Pola makan sehat dibutuhkan pada ibu menyusui sebagai makanan tambahan yaitu kalori ekstra sebesar 500 kilo kalori/hari, apabila bayi tidak mendapatkan ASI, berisiko terserang penyakit-penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan atas, dan infeksi lainnya (Kemenkes, 2016).

Gizi seimbang selama ibu menyusui adalah asupan energi yang bermanfaat untuk memproduksi ASI, sebagai bahan makanan perlu tambahan 330 kkal pada enam bulan pertama dan 400 kkal pada enam bulan kedua. Energi yg dibutuhkan untuk menghasilkan 100 cc susu sekitar 85 kkal. Protein di butuhkan tambahan 20g /hari selama enam bulan pertama dalam 100 cc . Asupan Lemak akan

mempengaruhi produksi ASI. Karbohidrat perlu tambahan 160-200 g /hari. Vitamin, harus cukup. Mineral di butuhkan lebih banyak dibanding hamil. Asupan Air minum bertambah sebanyak produksi ASI. Ibu sehabis menyusui minum segelas air putih untuk mengganti ASI yg keluar. (Yusrah Taqiyah, Rizqy Ifitah Alam, 2022), Berikut ini ada beberapa contoh makanan bergizi untuk Ibu menyusui sebesar 500 kilo/kalori untuk sarapan, makan siang, dan malam serta makanan selingan dan lengkap dengan jadwal makan Ibu menyusui

Contoh menu makanan ibu menyusui (Sahabat gizi) :

Sarapan/Breakfast

No	Jenis makanan	Jumlah makanan
1	Sereal	1 mangkuk
2	Pisang	1 potong kecil
3	Kacang walnuts,	1 sdm
4	Susu tanpa lemak	1/2 cangkir
5	Cangkir susu	1 ¼ cangkir
6	Telur dadar	1 telur
7	Roti gandum,	2 potong
8	Jus jeruk	1/2 cangkir

Makan Siang/Lunch

No	Jenis makanan	Jumlah makanan
1	Tuna	3 ons
2	Kacang almond	37 butir
3	Sandwich ayam panggang	2 potong
4	roti gandum	1 sdm
5	selai kacang, selai buah	1 sdm

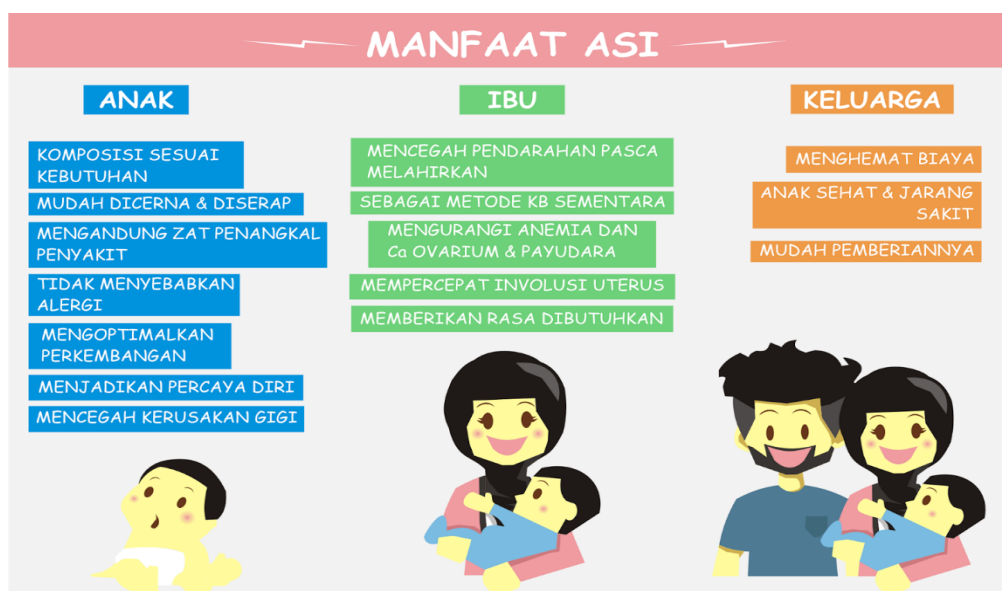
Makan Malam/Dinner

No	Jenis makanan	Jumlah makanan
1	Ikan salmon potong tanpa tulang	3 ons
2	1 buah roti gandum	
3	Sepiring nasi,	
4	Kacang polong dan brokoli rebus	

5	Makanan selingan/Snacks - o Apel - o pisang	3 buah 2 buah
---	--	------------------



Sumber : googleimage



Sumber : google image

D. Peran Perawat Dalam Melakukan Edukasi Pada Ibu Menyusui

Salah satu upaya strategis untuk menurunkan angka stunting di Indonesia adalah Pemberian ASI sejak dini oleh ibu menyusui dengan cara pemberian ASI

eksklusif bagi kelangsungan hidup anak untuk melindungi mereka agar memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan tidak mudah sakit, serta terhindar dari risiko diare. Tahun 2023 peringatan Pekan ASI Sedunia mengusung tema "*Enabling Breastfeeding: Making a Difference for Working Parents*" atau "Mengaktifkan Menyusui: Membuat Perbedaan Bagi Orang Tua Yang Bekerja". Tema nasionalnya adalah "Dukung Ibu Bekerja Terus. Tema kali ini berfokus pada menyusui dan dunia kerja dengan meyarakan hak-hak pekerja untuk keberhasilan menyusui, memberikan cuti melahirkan dan kebijakan pendukung. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif akan lebih mungkin mengalami kekurangan gizi dan vitamin A. Bayi juga berisiko terjadi alergi dan intoleransi laktosa. Selain itu, ada peningkatan risiko beberapa penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>

Perawat maternitas adalah salah satu tenaga kesehatan yang dapat berperan dalam membantu ibu postpartum mempersiapkan pemberian ASI dan berfungsi secara mandiri dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan maternitas dalam ruang lingkup individu, kelompok dan masyarakat pada ibu hamil, melahirkan dan masa nifas (Widiasih et al., 2022).

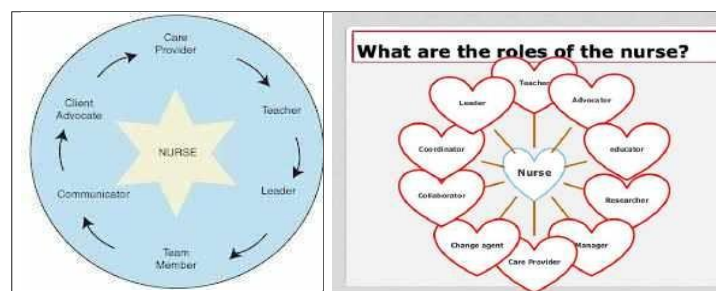


Sumber : google image



Sumber : googleimage

Perawat maternitas sebagai pemberi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab profesional dan peran multidimensional yaitu sebagai peran praktisi dengan melakukan pendekatan proses keperawatan yang berfokus pada kebutuhan fisik, emosional, spritual dan sosial berdasarkan konsep teori keperawatan yang dilakukan pada semua masalah kesehatan perempuan melalui asuhan keperawatan yang holistik dan komprehensif.



Sumber : googleimage

Peran *konselor* dengan melakukan kegiatan konseling pada klien dan keluarga dengan mengaplikasikan komunikasi teraupetik dan edukasi dalam mengambil keputusan pada personal maupun kelompok.



Sumber : google image

Peran *educator* dengan memberikan bimbingan dan pendidikan kesehatan.



Peran sebagai *inovator (change agent)* dengan melakukan perubahan-perubahan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, peran pengelola dengan melakukan manajemen keperawatan, peran kolaborator yaitu kolaborasi dengan dokter.



Sumber : google images

Peran *advokat* dengan melindungi hak-hak klien terkait program pengobatan dan perawatan.



Peran koordinator dan komunikator. Peran sebagai peneliti dengan menggunakan *evidence based nursing* yang bermanfaat bagi pelayanan keperawatan maternitas



E. Penutup

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang pemberian ASI eksklusif di Indonesia diberikan selama enam bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai usianya, hal ini menjadi tugas utama tenaga kesehatan di tatanan layanan kesehatan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan pada ibu yang baru melahirkan/ nifas untuk memberikan ASI secara eksklusif. (Kemenkes RI, 2019).

Pendidikan kesehatan terkait edukasi gizi pada ibu menyusui dapat dilakukan dengan menggunakan media, sebagai upaya mendukung keberhasilan dalam promosi kesehatan, media pendidikan adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan akan membantu elemen lain dalam penyampaian pesan kesehatan sehingga informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat penerimaan audien, hal ini sama dengan penelitian Munir dkk, 2023 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian edukasi kesehatan tentang ASI eksklusif, perawatan payudara, dan teknik menyusui yang benar di Bangka Belitung terhadap peningkatan pengetahuan Ibu hamil untuk mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif yang diketahui dari hasil pre test dan post test (Munir et al., 2023).

Gizi seimbang selama ibu menyusui adalah asupan energi yang bermanfaat untuk memproduksi ASI, sebagai bahan makananan perlu tambahan 330 kkal pada enam bulan pertama dan 400 kkal pada enam bulan kedua. Energi yg dibutuhkan untuk menghasilkan 100 cc susu sekitar 85 kkal. Protein di butuhkan tambahan 20g /hari selama enam bulan pertama dalam 100 cc . Asupan Lemak akan mempengaruhi produksi ASI. Karbohidrat perlu tambahan 160-200 g /hari. Vitamin, harus cukup. Mineral di butuhkan lebih banyak dibanding hamil. Asupan Air minum bertambah sebanyak produksi ASI. Ibu sehabis menyusui minum segelas air putih untuk mengganti ASI yg keluar. (Yusrah Taqiyah, Rizqy Iftitah Alam, 2022)

Referensi

- Anik, M. (2015). *Inisiasi Menyusu Dini, ASI EKSklusif dan Manajemen Laktasi* (A. M (ed.); 1st ed.). CV Trans Info Media.
- Diah Andriani Kusumastutia, S. E. (2022). Pengaruh P Endidikan N Utrisi I Bu P Ada I Nisiasi D Ini D An. *Jurnal Indonesia Kebidanan*, 6(1), 91–98.
- Kemenkes. (2016). Profil Kesehatan Indonesia. *Kemenkes RI, Jakarta*.
- Kemenkes, R. . (2011). *Direktorat Jendral Bina Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak. 2011. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 1995. MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standar Antopometri Penilaian Status Gizi Anak*.
- Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Manuaba, I. B. . (2012). *Buku Ajar Pengantar Kuliah Teknik Operasi Obstetri dan Keluarga Berencana* (C. T. I. Media (ed.)).
- Munir, R., Lestari, F., Nurhalimah, S. I., & Amalia, Y. (2023). *Edukasi Teknik Menyusui Yang Baik Dan Benar Pada Ibu Menyusui*. 1(1), 28–34.
- Naintina Lisnawati, Wilis Putu Purantira, A. R. (2023). Edukasi Pemberian Asi Pada Bayi Yang Baik Dan Benar Pada Ibu Menyusui Melalui Media Booklet. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(3), 948–961.
- Notoatmojo, S. (2010). *Ilmu perilaku kesehatan* (2nd ed.). Rineka Cipta.
- Prananingrum, R. (2021). Praktik Menyusui Yang Benar Di Bpm RahmA. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 9(2), 1–9.
- Widiasih, R., Komariah, M., Pramukti, I., Susanti, R. D., Agustina, H. S., Arifin, H., Kurniawati, Y., & Nelson, K. (2022). VNursLab 3D Simulator: A Web-Based Nursing Skills Simulation of Knowledge of Nursing Skill, Satisfaction, and Self-Confidence among Nursing Students. *Sustainability*, 14(9), 4882.
- Yusrah Taqiyah, Rizqy Iftitah Alam, F. J. (2022). Education of balanced nutrition needs in breastfeeding mothers in the partnership room ibnu sina rsu makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat*, 2(April), 5–8.

Glosarium

ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupan, tanpa tambahan makanan atau minuman lain

BBLR

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram.

Booklet

Booklet adalah buku kecil yang tipis dengan ukuran tertentu, biasanya A4 atau A5. Booklet berisi teks dan gambar yang digunakan sebagai media publikasi.

Edukasi

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik.

Gizi seimbang

pola makan yang memperhatikan jenis dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Pedoman gizi seimbang didasarkan pada empat pilar utama, yaitu: Konsumsi beragam jenis pangan, Melakukan aktivitas fisik, Menjaga berat badan ideal, Menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

BAB V

KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM MENDUKUNG IBU MENYUSUI.

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Kolaborasi Lintas Profesi dalam Mendukung Keberhasilan Menyusui

Keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada kesiapan ibu secara fisik dan emosional, namun juga ditentukan oleh dukungan profesional kesehatan yang terintegrasi. Kolaborasi lintas profesi, terutama antara bidan dan ahli gizi, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi ibu menyusui. Kolaborasi ini memastikan ibu mendapatkan dukungan menyeluruh yang mencakup aspek edukasi, konseling nutrisi, dan pemantauan kondisi kesehatan, sehingga proses menyusui berlangsung optimal (Setyowati & Wulandari, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan intervensi gabungan antara tenaga kebidanan dan ahli gizi memiliki tingkat keberhasilan menyusui lebih tinggi dibandingkan ibu yang hanya mendapat intervensi tunggal dari satu profesi saja (Kusumawati & Rahayu, 2024). Kolaborasi ini juga berperan penting dalam upaya pencegahan stunting dan malnutrisi pada bayi, karena menyusui yang optimal berhubungan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat (Sari & Sulastri, 2023).

Keterpaduan pelayanan antara bidan dan ahli gizi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi ibu dan bayi, tetapi juga memperkuat efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, model Interprofessional Education and Collaborative Practice (IPE-CP) yang melibatkan bidan dan ahli gizi terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas edukasi gizi dan menyusui di berbagai fasilitas kesehatan (Sudarmi & Aprina, 2020).

2. Tujuan dan Manfaat Sinergi Antara Bidan dan Ahli Gizi

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pelayanan kesehatan ibu menyusui melalui integrasi kompetensi kedua profesi tersebut. Adapun tujuan utama dari sinergi ini meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas Edukasi dan Konseling Menyusui

Bidan memiliki peran dalam memberikan edukasi tentang teknik menyusui, inisiasi menyusui dini, serta dukungan emosional. Di sisi lain, ahli gizi

bertanggung jawab dalam memberikan panduan nutrisi seimbang, guna memastikan ibu memiliki status gizi optimal yang diperlukan dalam produksi ASI yang memadai (Maharani & Khumairoh, 2023).

b. Mengoptimalkan Status Gizi Ibu dan Bayi

Kolaborasi ini bertujuan memastikan ibu mendapat asupan nutrisi yang tepat melalui rencana makan personalisasi yang disusun oleh ahli gizi, sementara bidan melakukan pemantauan rutin terhadap proses menyusui. Dengan status gizi yang baik, ibu dapat menghasilkan ASI dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, yang secara langsung mendukung tumbuh kembang bayi (Puspitasari & Yuniarti, 2021).

c. Pencegahan Masalah Kesehatan pada Ibu dan Bayi

Sinergi ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan menangani secara dini berbagai masalah menyusui, seperti mastitis, bendungan ASI, atau gangguan produksi ASI akibat status gizi yang kurang optimal. Dengan intervensi dini yang terintegrasi, komplikasi yang lebih serius dapat dicegah, sehingga mendukung keberlanjutan menyusui eksklusif hingga minimal enam bulan (Setyowati & Wulandari, 2022).

Manfaat dari kolaborasi ini telah didokumentasikan dalam berbagai penelitian terbaru yang melaporkan bahwa intervensi gabungan antara bidan dan ahli gizi berhasil meningkatkan durasi dan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, ibu yang mendapat dukungan gabungan ini melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan yang diterima (Kusumawati & Rahayu, 2024; Sari & Sulastri, 2023).

Kesimpulannya, sinergi antara bidan dan ahli gizi dalam mendukung ibu menyusui merupakan pendekatan strategis dalam memastikan pemenuhan hak bayi atas nutrisi terbaik, sekaligus memperkuat sistem kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

B. Peran Bidan dalam Mendukung Ibu Menyusui

Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran strategis dalam upaya mendukung keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Peran bidan dalam praktik kebidanan terkait menyusui diatur dalam Standar Pelayanan Kebidanan serta berbagai pedoman nasional dan internasional. Peran tersebut meliputi peran sebagai pendidik, pelaksana, advokat, dan konselor (Setyowati & Wulandari, 2022).

1. Bidan Sebagai Pendidik

Sebagai pendidik, bidan bertanggung jawab memberikan edukasi yang jelas dan komprehensif mengenai manfaat ASI eksklusif kepada ibu dan keluarga sejak

masa kehamilan hingga pascapersalinan. Informasi yang diberikan meliputi pentingnya menyusui eksklusif selama enam bulan, teknik menyusui yang benar, cara menyimpan ASI, serta pengelolaan berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi selama menyusui (Wahyuni & Ratnasari, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi ASI eksklusif yang dilakukan secara terstruktur oleh bidan sejak masa kehamilan berdampak signifikan pada peningkatan pengetahuan dan sikap ibu terhadap pemberian ASI, serta mampu memperpanjang durasi pemberian ASI eksklusif (Rohmawati & Andriani, 2021). Pendidikan yang disampaikan oleh bidan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya ibu agar pesan edukasi dapat diterima secara optimal (Kusumawati & Rahayu, 2024).

2. Bidan Sebagai Pelaksana

Dalam peran sebagai pelaksana, bidan secara aktif membantu proses Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah persalinan, memastikan kontak kulit antara ibu dan bayi berlangsung minimal satu jam setelah lahir. IMD terbukti efektif meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi, mempercepat produksi ASI, serta meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif (Hidayati & Fauziah, 2022).

Selain IMD, bidan juga bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap proses menyusui secara rutin. Pemantauan tersebut mencakup observasi posisi menyusui, pelekatan bayi pada payudara, serta mengevaluasi efektivitas pemberian ASI melalui indikator seperti berat badan bayi dan kondisi kesehatan ibu menyusui (Rahayu & Prabandari, 2022).

3. Bidan Sebagai Advokat

Sebagai advokat, bidan berperan penting dalam memperjuangkan hak ibu dan bayi untuk mendapatkan dukungan optimal selama proses menyusui. Bidan secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan, baik di tingkat institusional maupun komunitas, yang mendukung pemberian ASI eksklusif, seperti penyediaan ruang menyusui di tempat umum dan tempat kerja, perlindungan hak menyusui dalam peraturan ketenagakerjaan, serta kampanye publik tentang pentingnya menyusui eksklusif (Siregar & Nasution, 2020).

Peran bidan sebagai advokat juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung ibu menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa advokasi aktif dari bidan membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran komunitas mengenai pentingnya menyusui eksklusif (Wulandari & Yuniarti, 2021).

4. Bidan Sebagai Konselor

Peran konselor dilakukan bidan melalui pemberian dukungan emosional, psikologis, dan teknis kepada ibu menyusui. Konseling menyusui bertujuan membantu ibu mengatasi berbagai permasalahan psikologis seperti kecemasan, ketakutan akan kegagalan menyusui, hingga depresi pascapersalinan (Setyowati & Wulandari, 2022).

Konseling juga mencakup dukungan teknis, seperti membantu ibu menemukan posisi menyusui yang nyaman, teknik pelekatan bayi yang tepat, serta membantu ibu menghadapi berbagai tantangan menyusui seperti nyeri puting, mastitis, atau bendungan ASI (Hidayati & Fauziah, 2022). Dukungan ini diberikan melalui komunikasi empati, mendengarkan aktif, dan intervensi konseling yang berpusat pada ibu sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi ibu dalam menyusui (Rohmawati & Andriani, 2021).

Kesimpulannya, peran bidan dalam mendukung ibu menyusui sangat krusial dan multifungsi. Peran sebagai pendidik, pelaksana, advokat, dan konselor harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian target nasional dalam pemberian ASI eksklusif serta upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

C. Peran Ahli Gizi dalam Mendukung Ibu Menyusui

Ahli gizi merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang nutrisi dan dietetik, khususnya dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi ibu menyusui dan bayinya. Kolaborasi ahli gizi dengan tenaga kesehatan lain, terutama bidan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses menyusui serta mendukung pertumbuhan optimal bayi melalui perbaikan status gizi ibu (Kusumawati & Rahayu, 2024). Secara spesifik, peran ahli gizi meliputi penilaian status gizi, penyusunan rencana makan, pemberian edukasi gizi, dan mendukung program pencegahan stunting dan malnutrisi.

1. Menilai Status Gizi Ibu dan Bayi

Penilaian status gizi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam intervensi nutrisi untuk ibu menyusui. Ahli gizi melakukan penilaian ini melalui berbagai metode yang meliputi pengukuran antropometri seperti indeks massa tubuh (IMT), lingkaran lengan atas (LiLA), serta evaluasi klinis dan biokimia (misalnya kadar hemoglobin atau status zat besi ibu). Penilaian status gizi bayi juga dilakukan melalui pemantauan berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, dan interpretasi grafik pertumbuhan berdasarkan standar WHO (Rahayu & Supriyatin, 2022).

Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi status gizi secara berkala oleh ahli gizi mampu mencegah berbagai komplikasi

menyusui, termasuk produksi ASI yang tidak optimal akibat defisiensi mikronutrien (Rahmawati & Indriyani, 2023).

2. Menyusun Rencana Makan Sesuai Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui

Setelah penilaian status gizi, ahli gizi bertugas menyusun rencana makan yang spesifik dan personal untuk ibu menyusui. Rencana makan ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan energi tambahan sekitar 500 kkal per hari dibandingkan wanita tidak menyusui, serta kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi seperti zat besi, kalsium, asam folat, dan omega-3 (Fatimah & Wijayanti, 2023).

Dalam rencana makan tersebut, ahli gizi menentukan jenis, jumlah, dan frekuensi konsumsi makanan yang tepat berdasarkan prinsip gizi seimbang dan kondisi kesehatan khusus ibu. Rencana makan yang personal dan tepat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI, serta memperbaiki status kesehatan ibu secara umum (Susilawati & Setiani, 2021).

3. Memberikan Edukasi tentang Gizi Seimbang dan Pentingnya Nutrisi dalam Produksi ASI

Ahli gizi juga berperan sebagai edukator yang menyampaikan informasi penting terkait pola makan gizi seimbang kepada ibu menyusui dan keluarganya. Edukasi ini mencakup penjelasan detail mengenai kelompok pangan, porsi yang dianjurkan, pentingnya variasi makanan, serta konsumsi cairan yang cukup untuk mendukung produksi ASI (Puspitasari & Yuniarti, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan secara berkala oleh ahli gizi kepada ibu menyusui dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terhadap pola makan sehat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan status gizi ibu serta durasi menyusui eksklusif (Wulandari & Saraswati, 2022).

4. Berperan dalam Program Pencegahan Stunting dan Malnutrisi

Ahli gizi memiliki peran strategis dalam program pencegahan stunting dan malnutrisi di masyarakat, khususnya melalui intervensi dini terhadap ibu menyusui. Melalui edukasi yang tepat serta pemantauan status gizi secara teratur, ahli gizi berkontribusi dalam memastikan pemberian ASI yang optimal dan terpenuhinya kebutuhan nutrisi penting pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi (Rizkiyah & Andayani, 2024).

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa intervensi gizi sejak masa menyusui yang dilakukan oleh ahli gizi secara signifikan mampu mengurangi risiko terjadinya stunting dan malnutrisi pada bayi di berbagai wilayah di Indonesia (Kusumawati & Rahayu, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi aktif

ahli gizi dengan tenaga kesehatan lain dalam pendekatan terpadu dan multisektoral untuk mencegah masalah gizi kronis pada anak.

Kesimpulannya, ahli gizi memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan menyusui melalui berbagai intervensi nutrisi yang bersifat preventif, promotif, dan kuratif. Kolaborasi efektif antara ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya, terutama bidan, menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya tujuan gizi nasional, khususnya dalam program pencegahan stunting dan malnutrisi.

D. Model Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi merupakan model pelayanan kesehatan terpadu yang semakin dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan ibu dalam menyusui. Model kolaborasi ini mencakup aktivitas bersama dalam penyuluhan dan edukasi di komunitas, konsultasi dalam kasus khusus, pelatihan bersama untuk peningkatan kompetensi, serta implementasi pendekatan berbasis Interprofessional Education–Collaborative Practice (IPE-CP). Implementasi kolaborasi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara signifikan (Setyowati & Wulandari, 2022).

1. Kolaborasi dalam Penyuluhan dan Edukasi Gizi di Komunitas

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam penyuluhan gizi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya nutrisi ibu menyusui. Dalam praktiknya, bidan memberikan edukasi terkait manfaat dan teknik menyusui, sementara ahli gizi melengkapi informasi tersebut dengan materi mengenai pola makan sehat, kebutuhan nutrisi, serta pentingnya asupan mikronutrien (Kusumawati & Rahayu, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyuluhan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu dalam menerapkan pola makan yang mendukung produksi ASI. Penyuluhan bersama juga berdampak positif pada angka prevalensi ASI eksklusif serta menurunkan risiko malnutrisi pada bayi (Pratiwi & Sari, 2023).

2. Konsultasi Bersama dalam Kasus Ibu dengan Masalah Menyusui atau Gizi

Dalam kasus-kasus khusus di mana ibu mengalami masalah terkait menyusui seperti produksi ASI yang tidak mencukupi, penurunan berat badan bayi, atau ibu dengan kondisi gizi tertentu seperti anemia, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi menjadi kunci dalam memberikan solusi komprehensif. Konsultasi bersama memungkinkan adanya diagnosis terpadu yang mempertimbangkan

aspek teknis menyusui serta kebutuhan gizi ibu dan bayi secara simultan (Fatimah & Wijayanti, 2023).

Menurut hasil studi, konsultasi kolaboratif antara bidan dan ahli gizi mampu menghasilkan rekomendasi intervensi yang lebih efektif dibandingkan jika dilakukan secara terpisah oleh masing-masing profesi. Pendekatan ini juga meningkatkan kepuasan ibu terhadap layanan yang diterima karena memberikan solusi terintegrasi dalam satu waktu (Rahmawati & Indriyani, 2023).

3. Pelatihan Bersama untuk Meningkatkan Kompetensi dalam Mendukung Menyusui

Pelatihan bersama antara bidan dan ahli gizi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing profesi dalam mendukung keberhasilan menyusui. Materi pelatihan mencakup aspek klinis teknik menyusui, identifikasi dini masalah menyusui, serta edukasi nutrisi ibu menyusui. Pelatihan kolaboratif ini juga berfungsi sebagai media untuk saling bertukar informasi dan memperkuat komunikasi antarprofesi (Susilawati & Setiani, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan bersama mampu meningkatkan kompetensi profesional baik bidan maupun ahli gizi secara signifikan, khususnya dalam aspek intervensi gizi ibu menyusui. Kolaborasi pelatihan ini terbukti menghasilkan perubahan nyata dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari serta meningkatkan kualitas edukasi yang diberikan kepada ibu (Wulandari & Saraswati, 2022).

4. Implementasi Pendekatan Interprofessional Education–Collaborative Practice (IPE-CP) dalam Pelayanan Kesehatan

Interprofessional Education–Collaborative Practice (IPE-CP) merupakan pendekatan yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan yang bekerja secara bersama-sama, dengan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui kolaborasi efektif. Pendekatan ini melibatkan pelatihan lintas profesi sejak awal, yang bertujuan membangun kompetensi dalam kerja sama tim serta memperkuat pemahaman peran masing-masing profesi (Setyowati & Wulandari, 2022).

Implementasi IPE-CP dalam pelayanan kesehatan ibu menyusui melibatkan pelatihan, simulasi, dan evaluasi secara bersama-sama oleh bidan dan ahli gizi, serta tenaga kesehatan lain yang relevan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan kerja tim yang sinergis, meningkatkan hasil klinis berupa peningkatan prevalensi ASI eksklusif, dan memperbaiki status gizi ibu serta bayi (Kusumawati & Rahayu, 2024).

Studi terbaru menegaskan bahwa pendekatan IPE-CP di Indonesia mampu menjawab tantangan kompleks terkait pelayanan ibu menyusui melalui integrasi

praktik profesional yang lebih baik dan efektif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kompleks yang memerlukan intervensi multidisipliner (Rizkiyah & Andayani, 2024).

Secara keseluruhan, model kolaborasi bidan dan ahli gizi yang diimplementasikan secara terstruktur dan konsisten dapat menghasilkan dampak positif dalam mendukung keberhasilan menyusui, serta menjadi model strategis dalam upaya pencegahan berbagai masalah kesehatan ibu dan anak, termasuk stunting dan malnutrisi.

E. Studi Kasus dan Implementasi di Lapangan

Implementasi kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam mendukung ibu menyusui telah banyak dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun rumah sakit di Indonesia. Studi kasus berikut menggambarkan bagaimana kolaborasi yang efektif diimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan, serta hasil dan dampak yang ditimbulkan terhadap keberhasilan pemberian ASI dan perbaikan status gizi ibu serta bayi.

1. Contoh Kolaborasi di Puskesmas atau Rumah Sakit dalam Mendukung Ibu Menyusui

Salah satu contoh implementasi kolaborasi yang berhasil adalah program kolaboratif di Puskesmas X di Kota Surakarta. Dalam program ini, bidan dan ahli gizi bekerja sama secara aktif dalam sebuah tim terpadu. Setiap bulan diadakan kegiatan terpadu yang meliputi:

- a. **Konseling Menyusui Terpadu:** Bidan bertugas memberikan informasi terkait teknik menyusui yang benar, mengatasi masalah umum seperti pelekatan yang tidak optimal, dan masalah produksi ASI. Ahli gizi secara simultan memberikan edukasi gizi tentang pola makan sehat ibu menyusui, pemilihan makanan yang kaya nutrisi penting, serta strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI (Lestari & Handayani, 2023).
- b. **Pemantauan Bersama Status Gizi Ibu dan Bayi:** Bidan dan ahli gizi secara bersama-sama melakukan penilaian rutin, termasuk pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan biokimia (hemoglobin, kadar zat besi), serta evaluasi tumbuh kembang bayi secara berkala (Yuliani & Anggraini, 2021).

Studi serupa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yogyakarta, yang menerapkan program Interprofessional Collaborative Practice (IPCP) secara rutin. Dalam implementasi ini, bidan dan ahli gizi secara rutin berdiskusi tentang kasus-kasus yang ditemukan, baik masalah menyusui maupun gangguan gizi, yang kemudian disusun menjadi rekomendasi intervensi terpadu yang diberikan kepada pasien (Setyowati & Wulandari, 2022).

2. Hasil dan Dampak dari Kolaborasi terhadap Keberhasilan Menyusui dan Status Gizi Ibu dan Bayi

Dari implementasi kolaborasi di Puskesmas X Kota Surakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa angka cakupan ASI eksklusif meningkat secara signifikan, dari sebelumnya sebesar 56% menjadi 78% dalam waktu satu tahun sejak penerapan kolaborasi. Selain itu, angka kejadian anemia pada ibu menyusui menurun dari 34% menjadi 19%, menunjukkan perbaikan status gizi yang signifikan (Lestari & Handayani, 2023).

Di RSUD Yogyakarta, hasil evaluasi setelah penerapan IPCP memperlihatkan peningkatan yang nyata dalam durasi pemberian ASI eksklusif hingga usia enam bulan. Evaluasi klinis juga menunjukkan peningkatan rata-rata kenaikan berat badan bayi yang lebih optimal, serta penurunan insiden kasus gizi kurang pada bayi hingga 25% dibandingkan sebelum penerapan kolaborasi (Setyowati & Wulandari, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan di berbagai puskesmas di wilayah Jawa Timur menemukan bahwa kolaborasi terintegrasi antara bidan dan ahli gizi secara konsisten menghasilkan

peningkatan dalam pengetahuan dan sikap ibu menyusui tentang pentingnya ASI eksklusif dan nutrisi ibu. Efektivitas kolaborasi ini juga berdampak pada penurunan prevalensi stunting sebesar 18% dalam kurun waktu dua tahun implementasi (Widiastuti & Fitriani, 2024).

Secara umum, dampak positif dari implementasi model kolaborasi ini meliputi:

- a. Peningkatan Durasi Menyusui Eksklusif: Kolaborasi secara signifikan memperpanjang durasi ibu dalam memberikan ASI eksklusif hingga minimal enam bulan, yang secara langsung berkontribusi pada kesehatan optimal bayi.
- b. Perbaikan Status Gizi Ibu: Program kolaboratif menghasilkan peningkatan asupan nutrisi yang lebih baik, mengurangi kejadian anemia, dan secara keseluruhan memperbaiki kondisi kesehatan ibu menyusui.
- c. Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi: Penilaian berkala yang dilakukan secara kolaboratif membantu mendeteksi dan menangani dini permasalahan tumbuh kembang bayi, mengurangi kejadian stunting dan malnutrisi.

Dengan demikian, implementasi model kolaborasi ini secara konsisten terbukti efektif meningkatkan indikator-indikator penting kesehatan ibu dan anak, terutama dalam mendukung kebijakan nasional terkait peningkatan cakupan ASI eksklusif serta pencegahan stunting dan malnutrisi di Indonesia.

F. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi

Kolaborasi lintas profesi dalam bidang kesehatan, khususnya antara bidan dan ahli gizi dalam mendukung ibu menyusui, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut mencakup kendala komunikasi, perbedaan pendekatan profesional, serta prioritas masing-masing profesi. Namun, berbagai solusi efektif dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi (Setyowati & Wulandari, 2022).

1. Kendala Komunikasi dan Koordinasi Antar Profesi

Kendala komunikasi merupakan tantangan utama yang sering muncul dalam kolaborasi antara bidan dan ahli gizi. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masing-masing profesi mengenai peran dan tanggung jawab profesi lainnya, sehingga menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal (Pratiwi & Sari, 2023).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan terminologi dan gaya komunikasi profesional antar profesi juga sering menyebabkan kesalahpahaman yang dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Masalah ini dapat diperparah oleh kurangnya frekuensi pertemuan antar profesi, yang berujung pada koordinasi pelayanan yang tidak efisien dan fragmentasi intervensi (Susanti & Widodo, 2021).

2. Perbedaan Pendekatan dan Prioritas antara Bidan dan Ahli Gizi

Bidan dan ahli gizi memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda dalam menangani ibu menyusui. Bidan cenderung lebih fokus pada aspek klinis dan fisiologis menyusui, termasuk teknik menyusui, manajemen laktasi, serta dukungan emosional ibu. Di sisi lain, ahli gizi lebih berorientasi pada status nutrisi ibu dan bayi, pemenuhan kebutuhan makro dan mikronutrien, serta edukasi pola makan (Fatimah & Wijayanti, 2023).

Perbedaan prioritas ini kadang-kadang menimbulkan friksi dalam tim interprofesional. Sebagai contoh, bidan mungkin memprioritaskan teknik menyusui yang nyaman bagi ibu, sementara ahli gizi lebih menekankan pemenuhan asupan nutrisi. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan intervensi yang tidak sinkron, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan yang diberikan (Wulandari & Saraswati, 2022).

3. Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Kolaborasi

Berbagai solusi telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu melalui pelatihan bersama, forum diskusi rutin, dan dukungan kebijakan institusional yang jelas.

4. Pelatihan Bersama Antar Profesi

Pelatihan bersama antara bidan dan ahli gizi dapat meningkatkan pemahaman terhadap peran, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing profesi. Melalui pelatihan interprofesional, tenaga kesehatan tidak hanya memperoleh pengetahuan tambahan tetapi juga memperbaiki komunikasi, memperjelas ekspektasi peran, dan meningkatkan kolaborasi tim secara keseluruhan (Setyowati & Wulandari, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kolaboratif secara efektif mengatasi kendala komunikasi dan memperbaiki koordinasi, menghasilkan pelayanan terpadu yang lebih baik dalam mendukung ibu menyusui (Lestari & Handayani, 2023).

5. Forum Diskusi Rutin

Forum diskusi rutin merupakan pendekatan strategis dalam mengatasi kendala koordinasi antar profesi. Melalui forum ini, bidan dan ahli gizi secara berkala dapat bertemu untuk berdiskusi mengenai tantangan, perkembangan kasus, serta evaluasi intervensi yang sudah dilakukan (Widiastuti & Fitriani, 2024).

Studi terbaru menyebutkan bahwa forum diskusi rutin mampu memperkuat hubungan kerja antar profesi, meningkatkan pemahaman bersama, serta menghasilkan solusi yang lebih integratif dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi (Susanti & Widodo, 2021).

6. Kebijakan Institusional yang Mendukung Kolaborasi

Dukungan kebijakan institusional menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas kolaborasi. Institusi layanan kesehatan perlu mengembangkan kebijakan formal yang mendorong kerja sama antar profesi, menyediakan fasilitas dan waktu untuk pertemuan interprofesional, serta mengakui secara jelas peran dan kontribusi masing-masing profesi dalam tim (Rahmawati & Indriyani, 2023).

Hasil evaluasi implementasi kebijakan kolaborasi antar profesi di beberapa fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa adanya kebijakan yang jelas mampu memperkuat komitmen tenaga kesehatan terhadap kerja tim, meningkatkan kepuasan kerja, serta berdampak positif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada ibu menyusui dan bayi (Yuliani & Anggraini, 2021).

G. Penutup

1. Kesimpulan

Kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam mendukung keberhasilan menyusui merupakan pendekatan strategis yang penting untuk diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi berbagai aspek yang mencakup teknik menyusui yang tepat, status nutrisi ibu yang optimal, dukungan emosional, serta lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, integrasi antara peran bidan dan ahli gizi menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan kesehatan ibu dan bayi secara optimal (Setyowati & Wulandari, 2022).

Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa model kolaborasi interprofesional antara bidan dan ahli gizi mampu meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif secara signifikan, memperbaiki status gizi ibu dan bayi, serta memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kejadian stunting dan malnutrisi pada anak (Kusumawati & Rahayu, 2024; Lestari & Handayani, 2023). Meskipun menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan prioritas dan pendekatan profesi, berbagai strategi seperti pelatihan bersama, forum diskusi rutin, dan kebijakan institusional yang jelas terbukti efektif dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi tersebut (Widiastuti & Fitriani, 2024).

Kolaborasi bidan dan ahli gizi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan pelayanan yang lebih terintegrasi, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan ibu menyusui. Dengan demikian, pendekatan interprofesional ini menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kompleksitas masalah gizi dan kesehatan ibu serta bayi di Indonesia.

2. Rekomendasi untuk Praktik Kolaboratif yang Efektif di Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan hasil studi dan implementasi lapangan, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas praktik kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam mendukung ibu menyusui:

a. Penguatan Kompetensi melalui Pelatihan Bersama

Fasilitas kesehatan direkomendasikan untuk rutin mengadakan pelatihan kolaboratif antar profesi, yang mencakup aspek teknis laktasi, edukasi gizi, dan keterampilan komunikasi antarprofesi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi masing-masing profesi serta memperjelas peran dan tanggung jawab dalam tim interprofesional (Setyowati & Wulandari, 2022).

- b. Penyediaan Forum Diskusi Interprofesional secara Berkala
Institusi pelayanan kesehatan perlu menyediakan forum diskusi yang rutin dan terjadwal. Forum ini menjadi wadah penting bagi bidan dan ahli gizi untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang muncul, berbagi kasus klinis, mengevaluasi intervensi, serta merumuskan strategi bersama dalam pelayanan menyusui dan gizi ibu bayi (Susanti & Widodo, 2021).
- c. Pengembangan Kebijakan Institusional yang Mendukung Kolaborasi
Institusi pelayanan kesehatan perlu membuat kebijakan formal yang secara eksplisit mendukung kolaborasi antar profesi. Kebijakan ini meliputi penetapan standar operasional prosedur (SOP) kolaborasi, pengaturan jadwal kerja bersama, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja tim kolaboratif (Yuliani & Anggraini, 2021).
- d. Integrasi Pendekatan Interprofessional Education–Collaborative Practice (IPE-CP)
Institusi pendidikan tenaga kesehatan direkomendasikan mengintegrasikan pendekatan IPE-CP dalam kurikulum pendidikan bidan dan ahli gizi sejak masa pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya kolaborasi sejak dini, sehingga lulusan memiliki kesiapan yang optimal dalam praktik kolaborasi di tempat kerja (Setyowati & Wulandari, 2022).
- e. Monitoring dan Evaluasi Kolaborasi secara Berkelanjutan
Fasilitas kesehatan direkomendasikan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas implementasi kolaborasi, melalui indikator pencapaian ASI eksklusif, status gizi ibu dan bayi, serta kepuasan pelayanan ibu menyusui. Evaluasi berkala ini penting untuk memastikan kolaborasi tetap relevan, efektif, serta dapat diperbaiki secara kontinu (Widiastuti & Fitriani, 2024).
- b. Implementasi rekomendasi tersebut secara konsisten di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi efektif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional khususnya dalam peningkatan prevalensi ASI eksklusif dan penurunan angka stunting di Indonesia.

Referensi

- Hidayati, L., & Fauziah, S. (2022). Efektivitas Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Kebidanan Terpadu*, 4(1), 30-37.
- Kusumawati, D., & Rahayu, S. (2024). Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Program Pencegahan Stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 12(1), 45-52.
- Rahayu, T. A., & Prabandari, Y. S. (2022). Praktik Monitoring Menyusui oleh Bidan dan Dampaknya terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif. *Indonesian Midwifery and Health Journal*, 6(2), 150-158.
- Rohmawati, N., & Andriani, A. (2021). Pengaruh Edukasi Prenatal terhadap Durasi Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Primipara. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 9(1), 23-29.
- Setyowati, D., & Wulandari, P. (2022). Pentingnya Pendekatan Interprofessional Collaboration dalam Mendukung Ibu Menyusui di Indonesia. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 6(1), 1-9.
- Siregar, A., & Nasution, Z. (2020). Implementasi Advokasi Bidan terhadap Kebijakan Pendukung ASI Eksklusif di Rumah Sakit. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 4(2), 112-119.
- Wahyuni, D., & Ratnasari, I. (2023). Efektivitas Edukasi Menyusui yang Diberikan oleh Bidan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 11(1), 68-74.
- Wulandari, L., & Yuniarti, T. (2021). Peran Advokasi Bidan dalam Menurunkan Stigma Sosial terhadap Ibu Menyusui di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia*, 5(3), 167-175.
- Fatimah, D. A., & Wijayanti, E. (2023). Analisis Kebutuhan Nutrisi pada Ibu Menyusui dalam Mendukung Produksi ASI yang Optimal. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 11(2), 102-110.
- Kusumawati, D., & Rahayu, S. (2024). Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Program Pencegahan Stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 12(1), 45-52.
- Puspitasari, N., & Yuniarti, T. (2021). Asupan Nutrisi Ibu Menyusui dan Kaitannya dengan Keberhasilan ASI Eksklusif. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(3), 235-242.
- Rahmawati, N., & Indriyani, A. (2023). Penilaian Status Gizi pada Ibu Menyusui sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas ASI. *Indonesian Nutrition Journal*, 7(1), 25-32.
- Rahayu, T. A., & Supriyatin, M. (2022). Teknik Pengukuran Antropometri pada Ibu dan Bayi dalam Evaluasi Gizi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia*, 14(2), 112-119.

- Rizkiyah, A. N., & Andayani, S. (2024). Intervensi Gizi Spesifik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 45–52.
- Susilawati, H., & Setiani, O. (2021). Pengaruh Rencana Makan Personal terhadap Status Gizi dan Produksi ASI pada Ibu Menyusui. *Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia*, 16(3), 200–208.
- Wulandari, I., & Saraswati, H. (2022). Pengaruh Edukasi Gizi terhadap Pengetahuan Ibu Menyusui di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(2), 150–157.
- Pratiwi, A., & Sari, L. P. (2023). Efektivitas Penyuluhan Kolaboratif tentang Gizi dan Menyusui di Komunitas Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(1), 55–62.
- Setyowati, D., & Wulandari, P. (2022). Pentingnya Pendekatan Interprofessional Collaboration dalam Mendukung Ibu Menyusui di Indonesia. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 6(1), 1–9.
- Lestari, D., & Handayani, F. (2023). Efektivitas Kolaborasi Bidan dan Ahli Gizi dalam Program Penyuluhan Gizi dan Menyusui di Puskesmas Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(1), 28–36.
- Widiastuti, R., & Fitriani, E. (2024). Dampak Implementasi Program Kolaboratif antara Bidan dan Ahli Gizi terhadap Prevalensi Stunting di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 12–20.
- Yuliani, R., & Anggraini, N. (2021). Pengaruh Pemantauan Status Gizi Bersama oleh Ahli Gizi dan Bidan terhadap Status Kesehatan Ibu Menyusui. *Jurnal Gizi Klinis Indonesia*, 18(2), 80–88.
- Susanti, R., & Widodo, E. (2021). Hambatan Komunikasi Antarprofesi dalam Pelayanan Gizi dan Kebidanan. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(2), 112–118.

BAB VI

DAMPAK KURANG GIZI PADA IBU MENYUSUI TERHADAP PERTUMBUHAN BAYI

A. Pendahuluan

Masa menyusui merupakan periode krusial bagi ibu dan bayi karena asupan nutrisi yang cukup sangat menentukan kesehatan keduanya. Kurang gizi pada ibu menyusui dapat berdampak negatif terhadap kesehatannya sendiri serta mempengaruhi kualitas dan kuantitas Air Susu Ibu (ASI) yang dihasilkan. Kondisi ini juga dapat berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak kurang gizi pada ibu menyusui sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang tepat.

B. Konsep Gizi Dan Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui

Ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak menyusui. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral, sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan produksi ASI yang optimal. Pemenuhan gizi yang baik pada ibu menyusui sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu sekaligus memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang optimal melalui ASI. Pola makan seimbang dengan tambahan energi, protein, vitamin, mineral, serta hidrasi yang cukup dapat membantu mendukung produksi ASI berkualitas tinggi. Kekurangan nutrisi esensial dapat menyebabkan gangguan metabolisme, penurunan produksi ASI, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit.

C. Kurang Gizi Pada Ibu Menyusui

Kekurangan gizi pada ibu menyusui, atau disebut juga malnutrisi adalah kondisi tubuh yang tidak mendapatkan cukup energi, protein, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Ibu menyusui memiliki kebutuhan nutrisi yang meningkat untuk mendukung kesehatan ibu dan kualitas ASI yang dihasilkan yang meliputi:

1. Kebutuhan kalori

Ibu menyusui membutuhkan 2.000 hingga 2.7000 kalori perhari dan ini tergantung dari frekuensi menyusui dan metabolisme tubuh. Peningkatan kalori

ini diperlukan untuk memproduksi ASI dan untuk menjaga energi selama periode menyusui.

2. Makronutrien

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber utama energi yang diperlukan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas sehari-hari.

b. Protein

Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi serta pemulihan jaringan setelah melahirkan.

c. Lemak

Lemak berperan sebagai pembawa vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin (A, D, E, K) dalam ASI dan membantu perkembangan otak bayi.

3. Mikronutrien

a. Kalsium

Kalsium digunakan untuk pembentukan tulang ibu dan pertumbuhan tulang bayi

b. Zat Besi

Zat besi diperlukan untuk mencegah anemia pada ibu sekaligus mendukung perkembangan otak bayi.

c. Vitamin D

Vitamin D sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh.

d. Vitamin B (B2 dan B12)

Penting untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Vitamin B12 juga berperan untuk produksi sel darah merah yang sehat.

D. Penyebab Kekurangan Gizi Pada Ibu Menyusui

1. Asupan diet yang tidak memadai

Ibu menyusui mungkin tidak mengonsumsi cukup nutrisi karena kurangnya akses ke makanan yang beragam, kendala ekonomi, atau kurangnya pengetahuan gizi. Kekurangan ini dapat menyebabkan defisiensi nutrisi, yang mempengaruhi baik ibu maupun anak.

2. Kebutuhan nutrisi yang meningkat

Selama menyusui, tubuh seorang ibu membutuhkan nutrisi tambahan untuk memproduksi susu dan mendukung pertumbuhan bayi. Jika kebutuhan nutrisi yang meningkat ini tidak terpenuhi, ibu mungkin mengalami malnutrisi, yang berdampak pada kesehatannya dan kualitas ASI.

3. Tingkat Stres dan Kesehatan Mental

Stres dan depresi pasca melahirkan dapat mengurangi nafsu makan dan mempengaruhi metabolisme tubuh.

4. Faktor-faktor sosial ekonomi

Ketidakstabilan keuangan dan kurangnya akses ke makanan bergizi dapat sangat mempengaruhi kemampuan seorang ibu untuk menjaga pola makan yang sehat. Keyakinan budaya dan pendidikan terbatas tentang nutrisi semakin memperburuk masalah ini, yang mengarah pada pilihan diet yang buruk.

5. Kurangnya Edukasi Gizi

Minimnya pengetahuan tentang gizi yang dibutuhkan selama menyusui dapat menyebabkan pola makan yang tidak tepat.

E. Dampak Kurang Gizi Ibu Menyusui Terhadap Bayi

Kondisi gizi ibu selama masa menyusui sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nutrisi yang baik tidak hanya penting untuk kesehatan ibu, tetapi juga untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan bayi yang optimal sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi yang diterima selama masa menyusui. Jika ibu menyusui kurang gizi, dampaknya dapat bermanifestasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah rincian dampak tersebut:

1. Dampak Jangka Pendek

a. Gangguan Pertumbuhan fisik

Pertumbuhan merupakan proses peningkatan ukuran atau massa tubuh melalui peningkatan jumlah sel dan pembesaran ukuran sel atau jaringan tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang ukurannya dapat diukur secara langsung seperti tinggi badan, berat badan dan volume tubuh. Pertumbuhan ini berfokus pada ukuran fisik tubuh atau bagian tubuh. Proses perkembangan biasanya terjadi dengan cepat dimulai masa anak-anak hingga remaja.

Kekurangan nutrisi pada ibu menyusui mengakibatkan menurunnya produksi ASI dan menurunnya kualitas ASI yang dihasilkan. Jika ASI memiliki kandungan kalori yang rendah sedangkan bayi membutuhkan asupan kalori yang cukup dan itu didapatkan dari ASI sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan bayi.

Pertumbuhan bayi dapat diukur salah satunya dengan melihat berat badan bayi. Salah satu tanda utama bayi kurang mendapatkan ASI adalah kenaikan berat badan yang tidak memadai. Berat badan yang tidak naik sesuai kurva pertumbuhan merupakan salah satu indikator dari banyaknya indikator lain tanda kecukupan ASI. Secara normal bayi akan kehilangan 7%-10% berat

badan lahirnya dalam beberapa hari pertama setelah lahir dan akan kembali ke berat badan lahir pada usia 10-14 hari. Setelah itu, berat badan bayi akan naik sekitar 150-200 gram per minggu selama beberapa bulan pertama.

Kekurangan ASI pada bayi ditandai dengan berat badan bayi tidak kembali ke berat badan lahir pada usia 2 minggu, kenaikan berat badan kurang dari 150 gram per minggu setelah bayi berusia 2 minggu dan tidak ada kenaikan berat badan selama beberapa minggu berturut-turut.

Selain berat badan, tinggi/panjang badan juga sangat dipengaruhi nutrisi yang dikandung dalam ASI. Ibu yang mengalami malnutrisi akan menyebabkan kandungan nutrisi ASI akan berkurang sedangkan pertumbuhan tinggi badan bayi memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh bayi.

Lingkar kepala bayi juga merupakan salah satu indikator adanya kekurangan ASI pada bayi. Kekurangan nutrisi pada ibu menyusui terutama zat besi, iodium dan asam lemak omega-3 dapat mempengaruhi pertumbuhan lingkar kepala dan perkembangan otak bayi.

Zat gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik bayi antara lain:

1) Protein

Protein merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan pembentukan serum, enzim, haemoglobin, hormon dan antibodi, menjaga keseimbangan asam-basa tubuh, membangun, memelihara sel-sel tubuh dan memperbaiki sel yang rusak terutama pertumbuhan otot dan jaringan seperti mata, kulit, otot, jantung, paru-paru, otak dan organ lainnya.

Kekurangan protein dalam pertumbuhan bayi menyebabkan masalah pertumbuhan gigi dan rambut seperti rambut menjadi rapuh, mudah rontok dan lebih tipis selain itu dapat juga menyebabkan kulit menjadi kering dan kemerahan.

2) Lemak

Fungsi lemak dalam tubuh adalah menyuplai hampir setengah energi untuk kebutuhan sehari-hari, menjaga suhu tubuh, melindungi organ - organ penting dalam tubuh, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak serta lemak membantu menyediakan asam lemak esensial yang diperlukan untuk membantu perkembangan otak. Lemak yang terkandung dalam ASI termasuk asam lemak esensial seperti Omega-3 (DHA dan EPA) yang sangat penting untuk perkembangan sistem saraf dan fungsi kognitif. Kekurangan Lemak Omega-3 (DHA dan EPA) pada bayi juga mengurangi risiko gangguan penglihatan bayi.

3) Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama pertumbuhan dan aktivitas bagi bayi. Glukosa yang diperoleh dari karbohidrat sangat penting bagi kesehatan otak dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Jenis karbohidrat yang mudah dicerna bayi adalah laktosa yang terkandung dalam ASI. Selain itu dampak kekurangan karbohidrat akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bayi. Anak berisiko mengalami stunting yang mana kondisi gagal tumbuh sehingga tinggi badan anak lebih pendek dari usianya

4) Vitamin dan Mineral

Bayi dalam pertumbuhannya juga memerlukan beberapa vitamin dan mineral penting seperti: kalsium untuk perkembangan tulang dan gigi, Zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah dan pencegahan anemia pada bayi, vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor sebagai bagian penting dalam memelihara kesehatan tulang. Vitamin A untuk pertumbuhan sel dan fungsi mata dan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, gigi, gusi serta membantu penyerapan zat besi.

5) Air

Air walaupun bukan merupakan zat gizi, air sangat penting untuk menjaga hidrasi dan beberapa fungsi tubuh, termasuk pencernaan dan transport nutrisi. Kekurangan air atau cairan menyebabkan penurunan memori, fungsi visual-spasial, perfektif

b. Gangguan Perkembangan bayi

Perkembangan mengacu pada perubahan yang lebih kompleks dalam struktur dan fungsi tubuh. Dalam prosesnya melibatkan pembentukan organ baru, diferensiasi sel, dan perubahan dalam kemampuan fungsional. Proses tersebut akan berlangsung lebih rumit dan berlangsung selama fase kehidupan individu dimulai dari embrio hingga dewasa. Perkembangan bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur dengan angka karena mencakup perubahan dalam kemampuan mental, emosi dan keterampilan.

Bayi bergantung pada ASI untuk mendapatkan nutrisi penting. Jika seorang ibu kekurangan gizi dan tidak dapat memberikan ASI yang mengandung gizi yang cukup, hal ini dapat menghambat perkembangan motorik dan kognitif bayi. Pada tahap perkembangan bayi berkaitan dengan perkembangan otak bayi dan sistem syaraf bayi.

Nutrisi yang mempengaruhi perkembangan bayi:

1) Lemak

Lemak yang dimaksud adalah Asam Lemak Omega-3 (DHA dan EPA). Fungsi Asam Lemak Omega-3 khususnya DHA (asam dokosaheksaenoat) sangat penting untuk perkembangan dan fungsi otak karena DHA merupakan komponen utama dari membran sel otak dan diperlukan untuk Sinaps (penghubung antar sel).

Kekurangan asam lemak Asam Lemak Omega-3 (DHA dan EPA) pada bayi dapat menimbulkan

- Gangguan kesehatan seperti gangguan kognitif, memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah/*Intelligence Quotient* (IQ) yang lebih rendah, gangguan penglihatan.
- Gangguan penglihatan seperti gangguan ketajaman visual dikarenakan DHA merupakan komponen utama penyusunan retina mata.
- Masalah konsentrasi dan perilaku seperti kesulitan konsentrasi, gangguan tidur dan meningkatkan risiko gangguan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD).
- Gangguan imunitas/sistem kekebalan tubuh sehingga anak mudah menderita sakit/penyakit.
- Masalah mental dan emosional seperti salah satu penyebab depresi.

2) Protein

Protein yang diperlukan bayi berfungsi sebagai penyedia asam amino yang diperlukan untuk mensintesis neurotransmitter yang merupakan senyawa kimia yang mengkomunikasikan informasi antar sel-sel otak.

Kekurangan Protein pada perkembangan bayi menyebabkan:

- Gangguan fungsi otak seperti fungsi otak kurang maksimal dalam menyerap informasi.
- Penurunan sistem imun karena protein sebagai zat gizi pembentuk antibodi dalam tubuh.

3) Zat Besi

Zat besi penting untuk transportasi oksigen dalam darah ke otak dan keterlibatan dalam metabolisme energi. Kekurangan zat besi dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif.

Kekurangan Zat Besi pada bayi menyebabkan

- Anemia defisiensi zat besi sehingga bayi terlihat lesu lemah dan mudah lelah. Pada tahap selanjutnya bayi akan terlihat lesu, tidak aktif, tampak merintih, tidak tertarik untuk bermain atau berinteraksi dengan

lingkungan sekitar, lebih banyak tidur dan kurang responsif terhadap rangsangan

- Penurunan daya tahan tubuh karena cenderung akan mudah terserang penyakit.
- Gangguan kecerdasan kognitif seperti keterlambatan bicara dan penurunan kemampuan dalam belajar.
- Rewel dan perubahan perilaku seperti menjadi lebih rewel karena terjadinya penurunan produksi hormon dopamin yang berperan dalam perasaan bahagia.
- Kesulitan menyusui dikarenakan bayi kekurangan energi dampak dari bayi terlihat lemah dan lesu dalam beraktifitas.

4) Iodium

Iodium berfungsi untuk produksi hormon tiroid yang merupakan komponen penting dalam perkembangan otak. Kekurangan iodium, dapat menyebabkan kekurangan iodium pada bayi yang dapat mengganggu perkembangan tiroid dan otak. Kekurangan iodium yang parah akan dapat menyebabkan kretinisme yang ditandai dengan retardasi mental, gangguan pertumbuhan dan masalah pendengaran.

5) Zinc

Zink berperan dalam pembelahan sel dan perkembangan neuron. Zink berkontribusi pada fungsi kognitif, memori dan mendukung sistem imun tubuh. Kekurangan zinc akan menyebabkan bayi rentan terhadap infeksi dan penyakit seperti diare dan pneumonia.

c. Gangguan Metabolisme

Metabolisme adalah proses tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Gangguan metabolisme bayi adalah kondisi terganggunya proses metabolisme bayi sehingga bayi tidak dapat memproses nutrisi dengan baik.

1) Gangguan Metabolisme Karbohidrat

Bayi yang tidak dapat memproses karbohidrat dengan baik maka menyebabkan hipoglikemi (Kadar gula darah rendah).

2) Gangguan Metabolisme Lemak

Bayi yang tidak dapat memproses lemak dengan baik maka dapat menyebabkan hipolipidemia (Kadar lemak darah rendah)

3) Gangguan Metabolisme Protein

Bayi yang tidak dapat memproses protein menyebabkan hipoproteinemia (kadar protein darah rendah)

4) Gangguan Metabolisme Vitamin dan Mineral

Bayi tidak dapat memproses vitamin dan mineral dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral.

- Kandungan Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Kekurangan vitamin D pada ibu menyusui menyebabkan rendahnya kadar vitamin D dalam ASI sehingga dapat meningkatkan risiko pelunakan tulang (rakhitis) pada bayi.
- Kekurangan vitamin B12 pada ibu menyusui menyebabkan kadar vitamin B12 dalam ASI rendah, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf dan anemia pada bayi.
- Kekurangan zat besi pada ibu dapat menyebabkan kadar zat besi dalam ASI rendah. Zat besi merupakan komponen penting dalam perkembangan otak dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi pada bayi dapat menyebabkan bayi mengalami anemia dan gangguan kognitif.

d. Masalah Pencernaan

Kekurangan Nutrisi dalam ASI memengaruhi komposisi mikrobiota usus bayi yang dapat memengaruhi keseimbangan bakteri baik dan jahat dalam usus bayi sehingga dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare, sembelit dan kolik. Masalah pencernaan ini disebabkan ketidakmampuan sistem pencernaan untuk berfungsi dengan baik dikarenakan kekurangan zat nutrisi. Kekurangan nutrisi juga menyebabkan pelemahan sistem kekebalan tubuh bayi, sehingga bayi lebih rentan terhadap penyakit pencernaan serta akan mengalami keterlambatan dalam proses penyembuhan dikarenakan sistem imun tidak berfungsi secara optimal.

e. Masalah Emosional (*Bouding*)

Kekurangan nutrisi pada ibu menyusui menyebabkan ibu menderita kelelahan sehingga akan mengganggu aktifitas ibu termasuk dalam mengasuh bayinya termasuk menyusui. Menyusui adalah waktu yang penting untuk membangun ikatan (*bouding*) antara ibu dan bayinya melalui sentuhan dan kontak kulit. Saat ibu mengalami kelelahan maka ibu tidak maksimal melakukan kegiatan sehari-hari dalam merawat bayinya yang berakibat

kesempatan untuk membangun ikatan ini mungkin berkurang sehingga dapat memengaruhi perkembangan emosional bayi.

f. Sistem Kekebalan Tubuh Lemah

Kekurangan nutrisi pada ibu menyusui menyebabkan bayi lebih rentan terhadap infeksi. Kekurangan Vitamin A pada ibu dapat menyebabkan rendahnya kadar vitamin A dalam ASI sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi pada bayi, seperti infeksi saluran pernafasan dan diare. Bayi dengan asupan nutrisi yang tidak memadai dari ASI mungkin memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit selama tahap perkembangan yang krusial.

2. Jangka Panjang

a. Stunting

Stunting adalah kondisi terganggunya pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang, yang terjadi selama periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang disusui oleh ibu yang mengalami kurang gizi berisiko akan menyebabkan anak mengalami stunting.

b. Keterlambatan perkembangan kognitif

Kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif bayi. Gizi yang cukup dan seimbang yang didapat bayi melalui ASI yang diberikan ibu sangat penting untuk perkembangan saraf pusat dan fungsi otak bayi. Bayi yang lama mendapatkan nutrisi yang tidak memadai selama menyusui dapat menunjukkan tanda-tanda keterlambatan dalam perkembangan bahasa, pendengaran, kemampuan berfikir /memproses informasi dan hambatan dalam keterampilan sosial.

c. Masalah Kesehatan Jangka Panjang

Kekurangan gizi pada bayi yang ibunya mengalami kekurangan gizi memiliki dampak kesehatan jangka panjang yang meliputi:

- 1)** Pertumbuhan dan perkembangan yang lambat dan terhambat, baik dalam tinggi maupun berat badan. Anak akan memiliki postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa dan lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang seusianya.
- 2)** Beberapa penelitian menunjukkan kekurangan nutrisi pada masa bayi yang disebabkan kekurangan nutrisi pada ibu menyusui dapat meningkatkan risiko penyakit kronis dikemudian hari seperti obesitas, diabetes Tipe 2, penyakit kardiovaskuler, dan gangguan autoimun.

d. Dampak emosional dan Sosial

Keterbatasan nutrisi pada masa awal kehidupan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental di kemudian hari. Anak-anak yang mengalami malnutrisi pada bayi berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi.

Kekurangan gizi pada bayi akibat ibu yang menyusunya mengalami kekurangan gizi akan mempengaruhi perkembangan sosial anak, membuat anak kurang mampu berinteraksi dengan teman sebaya dan beradaptasi dalam situasi sosial.

Gangguan perilaku dapat terjadi pada bayi yang mengalami kekurangan nutrisi antara lain seperti perilaku sulit makan, pemilih makan (picky eater), perilaku makan yang tidak sehat.

e. Pendidikan dan Prestasi

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan gizi buruk cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih rendah, yang dapat berpengaruh pada peluang pendidikan dan pekerjaan di masa depan.

F. Penilaian Bayi Yang Mengalami Kekurangan Gizi

Penilaian terhadap bayi yang mengalami kekurangan nutrisi dari ibu menyusui yang kurang gizi dapat terlihat dari tanda-tanda sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Terhambat

Indikasi bayi dengan ibu menyusui yang kurang gizi yaitu berat badan bayi dan tinggi badan bayi berada di bawah rata-rata normal bayi seumurannya atau dibawah kurva pertumbuhan. Tanda lainnya kulit tampak kering dan rambut kering, mudah rontok, pipi dan mata tampak cekung, serta jaringan lemak dan otot berkurang, selain itu bayi terlihat mudah merasa lelah, terlihat lesu dan tidak semangat beraktifitas.

2. Perkembangan Terhambat

Perhatikan apakah ada keterlambatan dalam mencapai perkembangan bayi seperti berguling, duduk, merangkak atau bicara termasuk pertumbuhan intelektual dan perilaku yang lambat.

3. Masalah Makan

Nafsu makan atau menyusui menurun menjadi indikasi tanda kekurangan gizi, perhatikan apakah bayi menjadi sering rewel, gelisah saat menyusui atau makan atau menunjukkan tanda kehilangan minat makan.

4. Gangguan Pencernaan

Bayi sering mengalami gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit serta kolik.

5. Sering Sakit

Sistem kekebalan tubuh yang terganggu akibat kekurangan nutrisi menyebabkan bayi rentan menderita penyakit dan proses penyembuhan menjadi lebih lama.

6. Masalah Prilaku

Bayi tampak rewel mudah marah, gelisah dan kurang perhatian pada lingkungan sekitar.

G. Dampak Kekurangan Gizi Pada Ibu Menyusui

1. Penurunan Kualitas dan Kuantitas ASI

Kekurangan kalori dan cairan dapat mengurangi kemampuan ibu untuk memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup. Kekurangan ASI akan berdampak pada bayi baik dampak jangka panjang dan pendek pada bayi karena kekurangan ASI. Kandungan nutrisi dalam ASI dapat berkurang jika ibu mengalami defisiensi nutrisi seperti lemak, karbohidrat, protein mineral dan vitamin.

2. Tingkat energi yang menurun atau kelelahan.

Malnutrisi dapat menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan tingkat energi, sehingga menyulitkan ibu untuk melakukan tugas sehari-hari dan merawat bayi mereka dengan efektif.

3. Penurunan Massa Otot dan Berat Badan

Defisiensi protein dapat menyebabkan penurunan massa otot yang berpengaruh pada kekuatan fisik ibu.

4. Sistem kekebalan tubuh yang melemah

Kekurangan nutrisi penting dapat mengganggu sistem kekebalan ibu, meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi dan penyakit, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menyusui.

5. Gangguan Hormonal dan Siklus Menstruasi

Kurangnya nutrisi dapat mengganggu keseimbangan hormon yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi ibu.

6. Risiko depresi pascapersalinan

Kekurangan gizi telah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi pasca melahirkan, yang mempengaruhi kesejahteraan mental ibu dan kemampuan mereka untuk menjalin ikatan dengan bayi mereka.

H. Persyaratan Nutrisi

1. Asupan kalori yang cukup

Ibu menyusui memerlukan kalori tambahan untuk mempertahankan produksi susu dan memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Diet seimbang yang kaya kalori sangat penting untuk menjaga kesehatan.

2. Vitamin dan mineral esensial

a. Besi

Besi sangat penting untuk memproduksi hemoglobin, dan kekurangan dapat menyebabkan anemia, yang mempengaruhi energi ibu dan kualitas susu.

b. Kalsium

Kalsium sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mendukung perkembangan kerangka bayi. Kekurangan kalsium dapat membahayakan baik ibu maupun bayi.

c. Vitamin D

Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan masalah kesehatan tulang pada ibu dan masalah pertumbuhan pada bayi.

3. Sumber protein

Protein adalah zat pembangun untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Asupan protein yang cukup diperlukan untuk pemulihan ibu setelah melahirkan dan untuk memastikan produksi susu yang sehat.

I. Solusi Dan Intervensi

1. Konseling gizi

Mendidik para ibu menyusui tentang diet seimbang dan makanan kaya nutrisi dapat memberdayakan mereka untuk membuat pilihan diet yang lebih sehat, meningkatkan status gizi mereka dan kualitas susu.

2. Program suplementasi

Memberikan suplemen vitamin dan mineral dapat mengatasi kekurangan gizi tertentu, mendukung kesehatan ibu, dan memastikan bayi menerima nutrisi penting melalui pemberian ASI.

3. Inisiatif dukungan komunitas

Program komunitas dapat menawarkan sumber daya dan dukungan kepada ibu menyusui, seperti bank makanan, lokakarya gizi, dan kelompok dukungan sebaya, yang membantu mencapai hasil gizi yang lebih baik.

J. Dukungan Pemerintah Dan Kebijakan

1. Program pendidikan kesehatan

Kampanye edukasi yang dipimpin oleh pemerintah dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi ibu menyusui dan mendorong praktik diet yang lebih sehat di kalangan ibu menyusui.

2. Kebijakan kesehatan maternal

Kebijakan yang mempromosikan kesehatan ibu, termasuk cuti melahirkan dan program dukungan nutrisi, dapat memainkan peran penting dalam memastikan ibu menyusui memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjaga nutrisi yang memadai.

3. Akses ke layanan kesehatan

Memastikan bahwa ibu menyusui memiliki akses ke layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan panduan nutrisi, sangat penting untuk mendeteksi dan menangani malnutrisi bayi sejak dini.

K. Penutup

Kurang gizi ibu menyusui dapat berdampak pada kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi, baik secara fisik, kognitif, maupun emosi. Kekurangan gizi pada ibu menyusui dapat mengganggu produksi ASI dan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada bayi. Oleh karena itu, penting bagi ibu menyusui untuk memperhatikan asupan nutrisi mereka. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi harian, ibu menyusui dapat menjaga kualitas ASI dan kesehatan mereka sendiri, serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal.

Referensi

- Ahmad, F., & Rasmaniar, R. (2022). Gizi dalam daur kehidupan.
- Al-faida, N., Ardianti, D., & Ibrahim, N. S. I. (2024). Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Terhadap Status Gizi Bayi 0-6 Bulan Dan Tingkat Kecukupan Gizi Ibu Di Puskesmas Karang Tumaritis. *Jurnal Ilmiah Husada Askara*, 1(1).
- Almatsier, S., Soetardjo, S. and Moesijanti, S. 2011. Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Carretero-Krug, A., Montero-Bravo, A., Morais-Moreno, C., Puga, A. M., Samaniego-Vaesken, M. D. L., Partearroyo, T., & Varela-Moreiras, G. (2024). Nutritional status of breastfeeding mothers and impact of diet and dietary supplementation: a narrative review. *Nutrients*, 16(2), 301.
- Dewi, K., Anggriani, L., Ritonga, M. P., Azmi, C., Samosir, S. R., & Hutaaruk, F. N. (2023). Stunting dan pencegahannya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 18-26.
- Diana, F. M. (2013). Omega 3 dan kecerdasan anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 7(2), 82-88.
- Faridi, A. et al. (2022) Gizi dalam Daur Kehidupan. Edited by Matias Julyus Fika Sirait. Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=6t6fEAAAQBAJ>.
- Fembi, P. N., Nelista, Y., & Vianitati, P. (2024). Hubungan Asupan Nutrisi Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Stunting Pada Anak Balita. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3), 6189-6198.
- Khotimah, K., Satillah, S. A., Fitriani, V., Miranti, M., Maulida, M., Hasmalena, H., ... & Zulaiha, D. (2024). Analisis Manfaat Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu Menyusui dan Perkembangan Anak. *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 254-266.
- Likhar, A. and Patil, M.S. (2022) 'Importance of Maternal Nutrition in the First 1,000 Days of Life and Its Effects on Child Development: A Narrative Review', *Cureus*, 14(10), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.30083>.
- Mardani, M., Abbasnezhad, A., Ebrahimzadeh, F., Roosta, S., Rezapour, M., & Choghakhori, R. (2020). Assessment of nutritional status and related factors of lactating women in the urban and rural areas of southwestern Iran: a population-based cross-sectional study. *International journal of community based nursing and midwifery*, 8(1), 73.
- Nurhidayati, N., Fesmia, H. L., Putri, L. L., & Suryantini, N. K. M. (2023). Nutrisi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Dasar Perkembangan Kognitif: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Kedokteran*, 12(3).

- Priharwanti, A., Mastuti, D. N. R., Wasaraka, Y. N. K., Fatmawati, T. Y., Nurhayati, A., Astani, A. D., ... & Nabilah, I. (2024). *Buku Ajar Gizi Dalam Daur Kehidupan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadhini, D. (2023). *Ruang Lingkup Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*.
- Ramlah, U. (2021). Gangguan kesehatan pada anak usia dini akibat kekurangan gizi dan upaya pencegahannya. *Ana'Bulava: Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2), 12-25.
- Samaloisa, M. S. (2024). Keterlambatan perkembangan motorik anak akibat kurangnya asupan gizi. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(11).
- Segura, S. A., Ansótegui, J. A., & Díaz-Gómez, N. M. (2016). The importance of maternal nutrition during breastfeeding: Do breastfeeding mothers need nutritional supplements?. *Anales de Pediatría (English Edition)*, 84(6), 347-e1.
- Segura, S. A., Ansótegui, J. A., & Díaz-Gómez, N. M. (2016). The importance of maternal nutrition during breastfeeding: Do breastfeeding mothers need nutritional supplements?. *Anales de Pediatría (English Edition)*, 84(6), 347-e1.
- Supardi, N., Sinaga, T. R., Fauziah, F., Hasanah, L. N., Fajriana, H., Parliani, P., ... & Humaira, W. (2023). *Gizi pada Bayi dan Balita*. Yayasan Kita Menulis.
- Winarsih, B. D., Fatmawati, Y., & Hartini, S. (2021). Hubungan status gizi dan status hidrasi dengan fungsi memori jangka pendek anak usia sekolah. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(2), 115-130.

Glosarium

ASI : Air Susu Ibu

DHA :

EPA

hari pertama kehidupan (HPK)

Profil Penulis



Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

lahir di Jakarta 01 Januari 1974. Telah menyelesaikan studi DIII Keperawatan RS Islam Jakarta, strata satu di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (1998-2001). Lulus strata dua di Program Studi Ilmu Keperawatan dan Spesialis Maternitas Universitas Indonesia (2010-2014). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Akper Hermina Manggala Husada (2001-sekarang. Pernah menjabat Direktur (2014-2020). Ketua UPMI (2021- 2023). Saat ini sudah berubah perguruan tinggi menjadi Institut Kesehatan Hermina Pengampu mata kuliah Maternitas 1,2, Promosi Kesehatan, KDK. Jenjang Jabatan Akademik : Lektor Kepala , Organisasi yang diikuti PPNI Komisariat RS Hermina jatinegara, IPEMI DKI Jakarta, ILUNI UI FIK UI, WEC UI , DKLPT, ADI. Dosen Optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suryanihartati02@gmail.com



Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Palembang, 17 April 1995. Pendidikan tinggi yang sudah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Diploma IV Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang Tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Magister Kebidanan pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 disalah satu Perguruan Tinggi di Kota Palembang selama 8 bulan sebagai staf Laboratorium Kebidanan dan memutuskan berhenti bekerja untuk melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2019. Sekarang ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas Fisiologi – Patologi dan Terapi Non Konvensional dalam ruang lingkup kebidanan (kehamilan persalinan, nifas dan bayi). Penulis aktif dalam bermacam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi (ruang lingkup nifas dan terapi non konvensional), aktif mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop dan pelatihan, di samping itu Penulis juga melakukan banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan dosen lain. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: vikaharsandy@gmail.com
Motto: "Jangan berhenti untuk berkarya dan berbuat baik, karena semua hal akan ada jalan untuk menuju suatu niat yang baik".



Sri Raudhati, S.SiT., M.K.M.

Lahir di Peudada, 06 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1/D4 pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, STIKes Darussalam tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Aceh dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sebagai staff laboratorium Kebidanan Universitas Almuslim. Kemudian mulai tahun 2021 mengajar pada Prodi D3 Kebidanan Universitas Almuslim. Saat ini penulis bekerja di Universitas Almuslim Bireuen-Aceh, mengampu mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, dan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Koordinator Ukom Universitas Almuslim, dan Editor Jurnal Kesehatan Almuslim. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriraudhati@gmail.com.

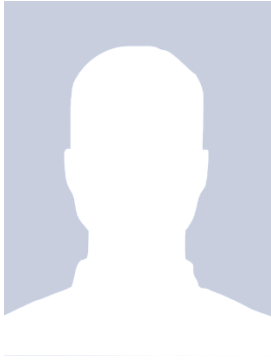
Motto: *"Success starts from the first step, so...keep going, never give up!!"*



Dr. Betty Yosephin Simanjuntak, SKM., MKM.

Lahir di Medan, 26 September 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S3 pada Program Studi Gizi Manusia Institut Pertanian Bogor dari tahun 2020-2015. Sebelumnya menempuh pendidikan Magister di Universitas Indonesia tahun 2004-2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 di Instalasi Gizi di salah satu Rumah Sakit pemerintah di Propinsi Bengkulu. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Bengkulu mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Gizi Reproduksi, Gizi dalam Daur Kehidupan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, mengikuti seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: betty_yosephin@poltekkesbengkulu.ac.id

Motto: *"Belajar dari kehidupan Semut, yang tidak pernah malas dan putus asa"*



Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.



Bdn. Ranny Septiani, SST., M.Keb.

Lahir di Tanjungkarang, 01 September 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III pada Program Studi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, Diploma IV di Program Studi DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2013 dan telah menyelesaikan Program Profesi Bidan Di STIKES Abdi Nusantara pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 hingga saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang mengampu beberapa matakuliah diantaranya mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan Essensial, Asuhan Kebidanan Nifas dan menyusui, Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Prodi DIII dan STR Kebidanan Tanjungkarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal nasional terakreditasi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rannyseptiani@poltekkes-tjk.ac.id.

Sinopsis

Buku referensi "**Edukasi Nutrisi untuk Ibu Menyusui**" hadir sebagai panduan lengkap yang membahas pentingnya pemenuhan nutrisi yang optimal selama masa menyusui. Masa menyusui adalah periode kritis di mana nutrisi ibu sangat menentukan kesehatan ibu sendiri dan tumbuh kembang bayi. Buku ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai kebutuhan gizi khusus yang diperlukan oleh ibu menyusui, seperti tambahan kalori, protein, vitamin, dan mineral, serta berbagai tips praktis dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola makan seimbang.

Pada bagian-bagian awal, pembaca akan diajak memahami konsep dasar nutrisi ibu nifas dan menyusui, pentingnya nutrisi dalam mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI), serta berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Bab-bab selanjutnya mengulas secara rinci makanan-makanan yang terbukti ilmiah mampu meningkatkan produksi dan kualitas ASI, dilengkapi dengan contoh menu sehari-hari yang mudah diaplikasikan oleh ibu menyusui.

Salah satu keunggulan buku ini adalah adanya pembahasan tentang pentingnya kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam memberikan edukasi nutrisi yang efektif bagi ibu menyusui. Sinergi ini dibahas melalui model-model kolaborasi praktis yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan durasi dan kualitas pemberian ASI eksklusif serta mencegah masalah kesehatan ibu dan bayi.

Lebih lanjut, buku ini mengupas berbagai dampak negatif yang bisa terjadi akibat kurang gizi pada ibu menyusui, seperti terhambatnya pertumbuhan bayi dan masalah kesehatan ibu. Buku ini juga menyajikan berbagai solusi dan intervensi nutrisi praktis serta dukungan kebijakan pemerintah yang dapat membantu ibu menyusui mencapai status gizi optimal.

Disusun berdasarkan penelitian terkini dan pengalaman lapangan, buku ini diharapkan menjadi referensi ilmiah sekaligus panduan praktis yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap gizi ibu dan bayi.

Buku referensi "Edukasi Nutrisi untuk Ibu Menyusui" hadir sebagai panduan lengkap yang membahas pentingnya pemenuhan nutrisi yang optimal selama masa menyusui. Masa menyusui adalah periode kritis di mana nutrisi ibu sangat menentukan kesehatan ibu sendiri dan tumbuh kembang bayi. Buku ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai kebutuhan gizi khusus yang diperlukan oleh ibu menyusui, seperti tambahan kalori, protein, vitamin, dan mineral, serta berbagai tips praktis dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola makan seimbang. Pada bagian-bagian awal, pembaca akan diajak memahami konsep dasar nutrisi ibu nifas dan menyusui, pentingnya nutrisi dalam mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI), serta berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Bab-bab selanjutnya mengulas secara rinci makanan-makanan yang terbukti ilmiah mampu meningkatkan produksi dan kualitas ASI, dilengkapi dengan contoh menu sehari-hari yang mudah diaplikasikan oleh ibu menyusui.

Salah satu keunggulan buku ini adalah adanya pembahasan tentang pentingnya kolaborasi antara bidan dan ahli gizi dalam memberikan edukasi nutrisi yang efektif bagi ibu menyusui. Sinergi ini dibahas melalui model-model kolaborasi praktis yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan durasi dan kualitas pemberian ASI eksklusif serta mencegah masalah kesehatan ibu dan bayi.

Lebih lanjut, buku ini mengupas berbagai dampak negatif yang bisa terjadi akibat kurang gizi pada ibu menyusui, seperti terhambatnya pertumbuhan bayi dan masalah kesehatan ibu. Buku ini juga menyajikan berbagai solusi dan intervensi nutrisi praktis serta dukungan kebijakan pemerintah yang dapat membantu ibu menyusui mencapai status gizi optimal. Disusun berdasarkan penelitian terkini dan pengalaman lapangan, buku ini diharapkan menjadi referensi ilmiah sekaligus panduan praktis yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap gizi ibu dan bayi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9618-0



9

786231

096180